Perfil V3 · código por código

Neurología

Los 62 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Neurología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 29 códigos

1.10.1.001 Cefalea tensional

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Cefalea tensional: la cefalea primaria más frecuente; opresiva «como un casco», bilateral (holocránea u occipitofrontal), leve a moderada, de 30 minutos a 7 días.
- No empeora con la actividad, nunca da náuseas ni vómitos y puede tener fotofobia o fonofobia, pero no ambas (diferencia con la migraña).
- Diagnóstico clínico con examen neurológico normal: sin banderas rojas (SNOOP10) no requiere TAC.
- Crisis: paracetamol o AINE (ibuprofeno 400–800 mg, naproxeno 500–550 mg); limitar analgésicos a <15 días/mes para evitar cefalea por abuso de medicación.
- Crónica (≥15 días/mes): profilaxis con amitriptilina 10–50 mg en la noche, manejo del estrés, ejercicio e higiene del sueño.
- Seguimiento completo en APS: registrar frecuencia y consumo de analgésicos; reevaluar ante cambio de patrón o bandera roja.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 59

Un paciente de 40 años consulta por cefalea holocránea, mayor en la zona occipital, que se irradia al cuello. Suele iniciarse a medio día y alcanza su máxima intensidad al llegar a su casa, después del trabajo. Su examen neurológico no tiene signos focales ni meníngeos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cefalea tensional
B) Migraña
C) Cefalea en racimo o cluster
D) Cefalea por hipertensión endocraneana
E) Neuralgia de Arnold

Respuesta A. Cefalea holocránea, occipital, que se irradia al cuello y aumenta a lo largo de la jornada, sin náuseas ni signos focales: cefalea tensional clásica. La migraña es unilateral y pulsátil con náuseas o foto y fonofobia; la hipertensión endocraneana predomina en la mañana.

1.10.1.002 Compromiso de conciencia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Cuantificar con Glasgow (ocular 4, verbal 5, motor 6): ≤8 = compromiso grave, indicación de intubar para proteger la vía aérea (con protección cervical si hay trauma).
- ABC, glicemia capilar inmediata, signos vitales, pupilas y búsqueda de focalidad, signos meníngeos y signos de herniación (midriasis unilateral, tríada de Cushing).
- Separar causa estructural (focalidad, pupilas asimétricas: ACV, hematoma, tumor) de tóxico-metabólica (pupilas reactivas, sin focalidad: hipoglicemia, hiponatremia, uremia, encefalopatía hepática, intoxicación, sepsis).
- Medidas iniciales: glucosa si hay hipoglicemia (tiamina antes en alcohólicos o desnutridos), naloxona si hay miosis y bradipnea, TAC de cerebro sin contraste.
- Fiebre con meningismo: hemocultivos, dexametasona y antibióticos antes de la imagen; herniación: cabecera a 30°, normoventilación y manitol o suero hipertónico.
- Seguimiento: derivar a UPC y al especialista según la causa (neurocirugía, neurología).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 35 años tras un accidente de tránsito: abre los ojos solo ante estímulo doloroso, emite sonidos incomprensibles y retira la extremidad ante el dolor. **¿Cuál es su puntaje en la escala de Glasgow y la conducta respecto de la vía aérea?**

A) Glasgow 6; solo ventilación con mascarilla
B) Glasgow 10; observar
C) Glasgow 8; requiere intubación para proteger la vía aérea
D) Glasgow 12; oxígeno por naricera
E) Glasgow 9; cánula orofaríngea y alta

Respuesta C. Apertura ocular al dolor suma 2, sonidos incomprensibles 2 y retiro ante el dolor 4: Glasgow 8. Un Glasgow de 8 o menos define un compromiso de conciencia grave y es indicación de intubación para proteger la vía aérea, con protección de la columna cervical. Luego se realiza TAC de cerebro.

1.10.1.003 Cuadros de deterioro orgánico cerebral potencialmente reversibles (hipotiroidismos, déficit de vitamina B12, etc.)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Ante todo deterioro cognitivo buscar causas potencialmente reversibles antes de rotular una demencia degenerativa.
- Laboratorio obligatorio: TSH (hipotiroidismo: bradipsiquia), vitamina B12, VDRL o RPR (neurosífilis), hemograma, electrolitos, función renal y hepática, glicemia y calcio.
- Neuroimagen (TAC o RM sin contraste): hematoma subdural crónico, tumores (meningioma frontal) e hidrocefalia normotensiva (marcha magnética, incontinencia y demencia).
- Déficit de B12: degeneración combinada subaguda (cordones posteriores y laterales) con neuropatía; tratar con cianocobalamina 1.000 μg IM; revierte si lleva <6–12 meses. Nunca ácido fólico solo.
- Descartar también depresión (pseudodemencia), fármacos (anticolinérgicos, benzodiacepinas), alcohol y déficit de tiamina.
- Seguimiento: no requiere seguimiento especial si se corrige la causa; reevaluar la cognición tras el tratamiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 104

Hombre de 72 años con cefalea holocraneal progresiva de 3 meses de evolución, asociada a ataxia de la marcha y deterioro cognitivo leve. TAC de cerebro: colección hipodensa crónicamente organizada entre el córtex y el hueso craneal, sin efecto de masa severo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tumor cerebral primario
B) Metástasis cerebrales
C) Hematoma subdural crónico
D) Hidrocefalia normotensiva
E) Enfermedad de Alzheimer

Respuesta C. Colección hipodensa crónica entre la corteza y el cráneo en un adulto mayor con cefalea, trastorno de la marcha y deterioro cognitivo: hematoma subdural crónico, causa estructural y tratable de deterioro cognitivo. Por eso la neuroimagen es obligatoria en el estudio.

1.10.1.004 Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores (afasia, apraxia, agnosia, etc)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Afasia de Broca (frontal inferior dominante): no fluente, con esfuerzo, comprensión relativamente conservada y conciencia del déficit.
- Afasia de Wernicke (temporal superior posterior dominante): fluente pero sin sentido, parafasias y neologismos, mala comprensión y repetición, anosognosia.

- Negligencia (parietal no dominante); apraxia ideomotora (no ejecuta gestos con fuerza conservada); agnosia visual y alexia sin agrafia (cerebral posterior).
- De inicio súbito orientan a ACV cortical de la cerebral media: código ACV, TAC sin contraste urgente y evaluar trombolisis.
- De instalación progresiva: tumor o demencia (afasia primaria progresiva de la demencia frontotemporal); estudiar con neuroimagen.
- Seguimiento: derivar a neurología y rehabilitación (fonoaudiología, terapia ocupacional).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años presenta en forma súbita un habla fluente pero sin sentido, con parafasias y neologismos. No comprende órdenes simples, no logra repetir frases y no parece darse cuenta de su déficit. No tiene paresia. **¿Cuál es la localización más probable de la lesión?**

A) Circunvolución frontal inferior izquierda (área de Broca)
B) Lóbulo parietal derecho
C) Porción posterior de la circunvolución temporal superior izquierda (área de Wernicke)
D) Cerebelo
E) Tronco encefálico

Respuesta C. Una afasia fluente con mala comprensión, mala repetición, parafasias y anosognosia es una afasia de Wernicke, por lesión de la porción posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, típicamente por un ACV de la división inferior de la arteria cerebral media izquierda. La afasia de Broca es no fluente, con comprensión relativamente conservada.

1.10.1.005 Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve · Tema 10.15 Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal

QUÉ HAY QUE SABER

- Demencia: deterioro cognitivo con pérdida de autonomía en actividades instrumentales (Pfeffer ≥6); DCL si el test está alterado pero conserva autonomía.
- Tamizaje: MMSE (<24, ajustado por escolaridad; en EMPAM, Minimental abreviado <13 + Pfeffer), MoCA (<26, más sensible para DCL) y test del reloj.
- Alzheimer: amnesia anterógrada insidiosa, anosognosia. Vascular: escalones y signos focales. Lewy: fluctuaciones, alucinaciones visuales y parkinsonismo. Frontotemporal: <65 años, desinhibición con memoria conservada.
- Estudio de causas reversibles en todos: TSH, B12, VDRL, perfil bioquímico y TAC o RM; en VIH avanzado considerar demencia asociada al VIH.
- Tratamiento inicial: Alzheimer leve-moderado donepezilo 5→10 mg con ECG basal (GES); memantina si MMSE <15; Lewy donepezilo y nunca haloperidol; vascular con control de riesgo vascular y aspirina.
- Seguimiento: derivar para confirmación y manejo especializado; apoyo al cuidador (Zarit). Agitación: medidas no farmacológicas, luego quetiapina en dosis baja; evitar benzodiacepinas.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 129

Paciente con 1 año de alucinaciones visuales, pérdida de memoria progresiva, rigidez, hipocinesia y alteración de la marcha. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Parkinson con demencia
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Demencia frontotemporal
D) Demencia por cuerpos de Lewy
E) Parálisis supranuclear progresiva

Respuesta D. Alucinaciones visuales, deterioro cognitivo y parkinsonismo que aparecen juntos, dentro del mismo año: demencia por cuerpos de Lewy. En la demencia de la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo precede a la demencia por más de un año.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 35

Un paciente de 82 años, hace 2 años sufrió un accedente vascular encefálico, sin secuelas. Hace 2 meses presenta un cuadro de labilidad emocional, desinhibición social y dificultades para realizar algunas de sus actividades habituales. **El diagnóstico más probable es:**

A) Depresión
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Demencia vascular
D) Demencia por cuerpos de Lewy
E) Hidrocéfalo normotensivo

Respuesta C. El antecedente de ACV en un adulto mayor que luego pierde funcionalidad orienta a demencia vascular; la labilidad emocional y la desinhibición sugieren compromiso subcortical y frontal. A los 82 años, la desinhibición no hace pensar en frontotemporal, que es presenil.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 85

Un paciente de 55 años ha presentado varios cambios congnitivos conductuales, como tendencia a la apatía, lenguaje coprolálico o andar desnudo. No ha tenido alteraciones en la conciencia ni en la memoria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Demencia por cuerpos de Lewy
B) Hidrocefalia normotensiva
C) Enfermedad de Alzheimer
D) Demencia frontotemporal
E) Delirium

Respuesta D. Menor de 65 años, apatía y desinhibición (coprolalia, andar desnudo) con memoria conservada: variante conductual de la demencia frontotemporal. Sin compromiso de conciencia, no es delirium.

Pregunta de práctica

Hombre de 71 años, profesor jubilado, traído por su hija por 16 meses de olvidos progresivos: repite las mismas preguntas, olvida citas y dejó la estufa encendida dos veces. Hace un mes se desorientó manejando al supermercado. Él minimiza el problema. Lúcido, atención normal. MMSE 21/30 (falla en memoria diferida y orientación), test del reloj muy alterado, Pfeffer 8 (dependiente para finanzas y electrodomésticos). Examen neurológico sin focalidad. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tranquilizar: son olvidos propios de la edad; control en un año
B) Diagnosticar deterioro cognitivo leve y control semestral sin fármacos
C) Solicitar TSH, B12, VDRL, perfil bioquímico y TAC cerebral, e iniciar donepezilo 5 mg/día
D) Iniciar memantina 20 mg/día como monoterapia
E) Iniciar lorazepam nocturno

Respuesta C. Deterioro amnésico anterógrado progresivo de más de un año, reloj alterado y Pfeffer 8 (pérdida de autonomía): demencia tipo Alzheimer leve a moderada, no DCL. Según GES: descartar causas reversibles (TSH, B12, VDRL, bioquímico), neuroimagen sin contraste e iniciar un IAChE (donepezilo 5 mg/día), más apoyo al cuidador. Memantina es para MMSE < 15; las benzodiacepinas están contraindicadas.

1.10.1.006 Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.11 Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras · Tema 10.12 Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

QUÉ HAY QUE SABER

- Parkinsonismo: bradicinesia (golpeteo de dedos que decrece) obligatoria + temblor de reposo 4–6 Hz o rigidez en rueda dentada; asimétrico al inicio. Diagnóstico clínico.
- Pródromos: hiposmia, constipación, trastorno conductual del sueño REM y depresión; inestabilidad postural es tardía.
- Excluir parkinsonismo por fármacos (metoclopramida, antipsicóticos, flunarizina, cinarizina): simétrico y subagudo; se suspende el fármaco sin dar levodopa.
- Banderas rojas de Parkinson-plus: caídas precoces y mirada vertical hacia abajo (PSP), disautonomía grave precoz (AMS), apraxia y mano ajena (corticobasal), marcha a pasos cortos con braceo normal (vascular).
- Tratamiento inicial: ≥65 años levodopa/carbidopa 100/25 mg c/8 h lejos de las proteínas; jóvenes agonista (pramipexol) o IMAO-B, vigilando control de impulsos.

- GES: confirma el neurólogo; con los años wearing-off (fraccionar, entacapona) y disquinesias (amantadina).

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 22

Un hombre de 55 años, diabético de larga data, presenta temblor de reposo y lentitud al realizar actividades, como vestirse, lo que se ha asociado a dificultades para iniciar la marcha. Relata que se había caído hacia adelante, en dos oportunidades, al empezar a caminar. Al inicio de la marcha es lento e inseguro, pero luego alcanza una velocidad normal, la que se mantiene por el resto del tiempo. No presenta disminución de las fuerzas de las extremidades y sus reflejos osteotendíneos son normales, al igual que la sensibilidad. **El diagnóstico más probable es:**

A) Enfermedad de Parkinson
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Polineuropatía diabética
D) Polimialgia reumática
E) Miopatía por cuerpos de inclusión

Respuesta A. Temblor de reposo + bradicinesia (lentitud para vestirse) + dificultad para iniciar la marcha: enfermedad de Parkinson. Fuerza, reflejos y sensibilidad normales descartan la polineuropatía diabética y las miopatías.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 99

Un paciente de 62 años, con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con doxazosina, hiperplasia prostática benigna en tratamiento con tamsulosina y trastorno afectivo bipolar en tratamiento con carbonato de litio, consulta por temblor de manos mayor a derecha que aparece con el reposo y se asocia a lentitud en los movimientos. El cuadro inició hace 4 meses. Se miden los niveles plasmáticos de los fármacos que utiliza, los que son informados dentro de rango terapéutico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender la doxazosina
B) Disminuir la dosis de carbonato de litio
C) Suspender la tamsulosina
D) Realizar prueba con levodopa
E) Iniciar propranolol vía oral

Respuesta D. Temblor de reposo asimétrico + bradicinesia: enfermedad de Parkinson, de diagnóstico clínico; la respuesta a levodopa apoya el diagnóstico. El litio puede dar temblor, pero los niveles están en rango. El propranolol es para el temblor esencial.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 26

Un paciente de 70 años presenta un cuadro de dificultad para girarse y para meterse a la tina, asociado a múltiples caídas. Además presenta cambios en la escritura y temblor de reposo. No presenta deterioro cognitivo evidente. **El diagnóstico más probable es:**

A) Atrofia generalizada
B) Hidrocefalia normotensiva
C) Temblor senil
D) Demencia por cuerpos de Lewy
E) Enfermedad de Parkinson

Respuesta E. Bradicinesia (dificultad para girarse), micrografía y temblor de reposo: enfermedad de Parkinson. Sin deterioro cognitivo no calza la demencia por cuerpos de Lewy ni la hidrocefalia normotensiva, y el temblor de reposo no es un temblor "senil".

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años con 14 meses de temblor de la mano derecha que aparece con el brazo apoyado y cede al tomar una taza. Camina más lento y perdió expresividad facial. Examen: hipomimia, hipofonía, braceo derecho disminuido, pasos cortos, rigidez en rueda dentada en muñeca y codo derechos, temblor de reposo de 5 Hz y golpeteo de dedos lento y decreciente a derecha. Sin caídas, sin alteración oculomotora ni disautonomía. **¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada?**

A) Propranolol 40 mg cada 12 horas
B) Pramipexol como monoterapia para postergar la levodopa
C) Levodopa/carbidopa 100/25 mg cada 8 horas, lejos de las comidas proteicas
D) Diferir el tratamiento hasta que aparezca inestabilidad postural
E) Amantadina 100 mg cada 12 horas

Respuesta C. Parkinson idiopático con criterios MDS: bradicinesia (finger tapping decreciente) + temblor de reposo + rigidez, asimétrico y sin banderas rojas. En mayores de 65 años se inicia levodopa/carbidopa, alejada de las comidas proteicas. Los agonistas se reservan para menores de 65; la amantadina es para disquinesias; el propranolol es para el temblor esencial.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 40 · texto original del banco, sin revisar

Paciente en tratamiento anti hipertensivo + sd vertiginoso en tto con Cinarizina, metformina, inicia temblor de reposo, simétrico, bilateral, rigidez y asociado a caídas frecuentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Parkinson POR QUÉ NO PODÍA SER PÁRKINSON ? Porque describía un temblor bilateral simétrico, Parkinson inicia como unilateral y no simétrico
B) Parkinsonismo por fármacos
C) Accidente cerebrovascular
D) Epilepsia
E) Esclerosis múltiple

Respuesta A. Diagnóstico: Parkinson POR QUÉ NO PODÍA SER PÁRKINSON ? Porque describía un temblor bilateral simétrico, Parkinson inicia como unilateral y no simétrico (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

1.10.1.007 Epilepsia

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.8 Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES · Tema 10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Epilepsia (ILAE): 2 crisis no provocadas separadas >24 h, o 1 con riesgo de recurrencia >60% (lesión en imagen o EEG epileptiforme).
- Clasificar el inicio: focal (con o sin alteración de conciencia, automatismos, evolución a bilateral) o generalizado (tónico-clónica, ausencias con punta-onda 3 Hz, mioclonías de la EMJ).
- Estudio: EEG (normal en la mitad; repetir con privación de sueño) y RM con protocolo de epilepsia; TAC solo en urgencia.
- Fármaco según crisis y paciente: focal lamotrigina, levetiracetam o carbamazepina; generalizada valproato en hombres; mujer fértil lamotrigina o levetiracetam + ácido fólico 5 mg; adulto mayor levetiracetam.
- Toxicidades: valproato teratógeno; carbamazepina hiponatremia y Stevens-Johnson; fenitoína hiperplasia gingival; levetiracetam irritabilidad. Carbamazepina y fenitoína agravan ausencias y mioclonías.
- GES en ≥15 años: especialista y EEG en 30 días; no conducir. Derivar a centro de epilepsia si fallan 2 fármacos bien usados (refractaria).

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 143

Paciente con mirada forzada hacia la derecha, luego espasmo hemifacial, luego movimientos de sacudidas en las 4 extremidades. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Crisis focal con generalización secundaria
B) Crisis tónico-clónica generalizada primaria
C) Estatus epiléptico no convulsivo
D) Accidente isquémico transitorio (AIT)
E) Crisis mioclónica juvenil

Respuesta A. La crisis parte con signos focales (desviación forzada de la mirada, espasmo de una hemicara) y luego compromete las 4 extremidades: crisis focal con evolución a tónico-clónica bilateral (antigua secundariamente generalizada). El signo inicial define el inicio focal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 133

Una paciente de 14 años sufre una convulsión tónico clónica, luego de una noche con privación de sueño y exposición a pantallas. Previo a esto, presentaba movimientos bruscos, como sacudidos, de manera involuntaria. Sus amigas relatan que en ocasiones "se queda pegada" por algunos segundos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Epilepsia mioclónica juvenil
B) Epilepsia de ausencia juvenil
C) Epilepsia tónicoclónica
D) Epilepsia focal
E) Crisis convulsiva por privación de sueño

Respuesta A. Adolescente con mioclonías, ausencias ocasionales y una convulsión tónico-clónica gatillada por privación de sueño: epilepsia mioclónica juvenil, que combina los tres tipos de crisis generalizadas. La privación de sueño es el gatillante, no el diagnóstico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 41

Un niño de 16 años convulsiona al despertar, en la mañana siguiente de haber estado jugando videojuegos hasta tarde. Además, refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Suspender por completo los videojuegos
B) Ácido valproico
C) Carbamazepina
D) Melatonina en la noche
E) Diazepam si convulsiona nuevamente

Respuesta B. Epilepsia mioclónica juvenil en un hombre: el fármaco más efectivo es el ácido valproico. La carbamazepina agrava las mioclonías y las ausencias. En una mujer en edad fértil se preferiría lamotrigina o levetiracetam.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 140

Niño o adolescente con conducta disruptiva + crisis de ausencia. **¿Como estudiarlo?**

A) Electroencefalograma
B) TAC
C) RNM
D) Psicometria
E) Control sano habitual

Respuesta A. Ante la sospecha de crisis de ausencia, el examen de elección es el electroencefalograma, que muestra la punta-onda generalizada a 3 Hz, patognomónica. La neuroimagen no es el estudio inicial de una epilepsia generalizada, y la psicometría confunde las ausencias con un problema de conducta o atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 41

Adolescente de 16 años convulsiona al despertar, en la mañana siguiente de haber estado jugando videojuegos hasta tarde. Además refiere mioclonías matinales frecuentes desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Suspender por completo los videojuegos
B) Ácido valproico
C) Carbamazepina
D) Melatonina en la noche
E) Diazepam si convulsiona nuevamente

Respuesta B. Mioclonías matinales más una crisis tónico-clónica al despertar tras privación de sueño: epilepsia mioclónica juvenil, una epilepsia generalizada que requiere tratamiento prolongado. El ácido valproico es de elección en varones (en mujeres en edad fértil se prefiere levetiracetam o lamotrigina). La carbamazepina agrava mioclonías y ausencias; evitar trasnochar ayuda, pero no reemplaza el fármaco.

Pregunta de práctica

Mujer de 26 años, recién casada, desea embarazarse a corto plazo. Tiene epilepsia generalizada idiopática diagnosticada a los 16 años, sin crisis hace 3 años con ácido valproico 500 mg cada 12 horas. Examen neurológico normal; hemograma y pruebas hepáticas normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener el ácido valproico y agregar ácido fólico 1 mg al día
B) Suspender de inmediato el ácido valproico
C) Cambiar gradualmente a lamotrigina o levetiracetam e indicar ácido fólico 5 mg al día desde 3 meses antes de concebir
D) Cambiar a carbamazepina, por su menor teratogenicidad
E) Contraindicar el embarazo

Respuesta C. El valproato es el antiepiléptico más teratogénico (tubo neural 1–2 %, cardiopatías, autismo, bajo CI) y está contraindicado en la mujer en edad fértil. Se rota de forma programada y gradual a lamotrigina o levetiracetam, con ácido fólico 5 mg/día desde 3 meses antes de la concepción. Suspender bruscamente expone a crisis; la carbamazepina agrava las epilepsias generalizadas.

1.10.1.008 Esclerosis múltiple

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.18 Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad · Tema 15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Mujer de 20–45 años con déficits focales separados en tiempo y espacio: neuritis óptica (baja visual con dolor al mover el ojo, discromatopsia, DPAR), mielitis parcial u oftalmoplejía internuclear.
- Signos: Uhthoff (empeora con calor, no es brote) y Lhermitte (descarga al flectar el cuello).
- Diagnóstico (McDonald 2017): RM con lesiones periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales o medulares (diseminación en espacio) y lesiones que captan y no captan (tiempo); bandas oligoclonales en LCR sustituyen la diseminación en tiempo.
- Brote (déficit nuevo >24 h sin fiebre): metilprednisolona 1 g/día EV por 3–5 días, sin descenso oral; plasmaféresis si no responde.
- Diferencial clave: neuromielitis óptica (neuritis bilateral grave, mielitis ≥3 vértebras, anti-acuaporina 4), que empeora con interferón y natalizumab.
- Seguimiento: no lo hace el médico general; derivar a neurología para terapia modificadora (GES).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 104

Una paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace una semana se agrega disminución de la sensibilidad del muslo derecho, con dificultades para caminar. Como antecedente, refiere que hace un año tuvo un trastorno del equilibrio, que resolvió espontáneamente. **El diagnóstico más probable es:**

A) Polineuropatía por déficit de vitamina B12
B) Síndrome de Guillain Barré de presentación atípica
C) Infarto talámico
D) Esclerosis múltiple
E) Neurinoma con compresión del troncoencéfalo

Respuesta D. Mujer joven con neuralgia de la primera rama (atípica, sugiere causa secundaria), más un déficit sensitivo nuevo y un episodio previo de desequilibrio que remitió: lesiones en distintos sitios y momentos. Es una esclerosis múltiple, causa clásica de neuralgia del trigémino secundaria.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 17

Una paciente de 14 años presenta disminución de la visión del izquierdo, de dos días de evolución. Su agudeza visual es 20/200 en el ojo izquierdo y 20/20 en el derecho. Tiene antecedente de hemiparesia braquial. Al fondo de ojo se observa papilitis izquierda. Su resonancia magnética nuclear muestra lesiones desmielinizantes cerebrales. **El diagnóstico más probable es:**

A) Desprendimiento de retina
B) Neuritis óptica
C) Neuropatía óptica isquémica
D) Degeneración macular
E) Hipertensión endocraneana

Respuesta B. Baja visual monocular en días, antecedente de otro déficit focal y lesiones desmielinizantes en la RM: neuritis óptica en el contexto de esclerosis múltiple. Un tercio de las neuritis muestra edema de papila (papilitis), que es unilateral; el edema de papila bilateral orienta a hipertensión endocraneana.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 104

Una paciente de 30 años presenta un cuadro de 1 mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace 1 semana se agrega disminución de la sensibilidad del muslo derecho, con dificultades para caminar. Como antecedente, refiere que hace 1 año tuvo un trastorno del equilibrio, que resolvió espontáneamente. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Polineuropatía por déficit de vitamina B12
B) Síndrome de Guillain-Barré de presentación atípica
C) Infarto talámico
D) Esclerosis múltiple
E) Neurinoma con compresión del troncoencéfalo

Respuesta D. Mujer joven con múltiples déficits focales separados en el espacio (trigémino, sensibilidad de extremidad, equilibrio) y en el tiempo, de inicio subagudo y con recuperación espontánea: es la definición clínica de esclerosis múltiple. Se estudia con resonancia magnética con gadolinio.

Pregunta de práctica

Mujer de 26 años, profesora, con 3 días de baja visual del ojo derecho y dolor retroorbitario que empeora al mover los ojos; ve los rojos "deslavados". Hace un año tuvo parestesias en la pierna izquierda por 2 semanas, que cedieron solas. AV OD 20/100, OI 20/20; DPAR derecho; fondo de ojo normal. RM: lesiones periventriculares perpendiculares a los ventrículos y una yuxtacortical; dos captan gadolinio. LCR: 4 bandas oligoclonales IgG ausentes en suero. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Prednisona oral 1 mg/kg/día con descenso gradual
B) Metilprednisolona EV 1 g/día por 3 a 5 días y derivar a neurología (GES)
C) Natalizumab EV como primera medida
D) Observar y repetir la RM en 6 meses para confirmar diseminación en tiempo
E) Plasmaféresis de inmediato

Respuesta B. Neuritis óptica retrobulbar en una mujer joven con RM que cumple diseminación en espacio y en tiempo (lesiones que captan y no captan), además de bandas oligoclonales: esclerosis múltiple remitente-recurrente. El brote se trata con metilprednisolona EV 1 g/día por 3–5 días y se deriva para inicio de terapia modificadora GES. No hay que esperar otra RM; la plasmaféresis es rescate si falla el corticoide.

1.10.1.009 Herpes zoster

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.8 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt

QUÉ HAY QUE SABER

- Herpes zóster: reactivación del virus varicela-zóster en un ganglio sensitivo; dolor urente o pródromo de parestesias seguido de vesículas agrupadas en un dermatoma, unilateral, que no cruza la línea media.
- Más frecuente en mayores de 50 años e inmunosuprimidos; diagnóstico clínico.
- Tratamiento antiviral idealmente en las primeras 72 h: valaciclovir 1 g c/8 h o aciclovir 800 mg 5 veces al día por 7 días; analgesia según dolor.
- Formas especiales: oftálmico (V1; vesícula en la punta de la nariz = signo de Hutchinson, derivar a oftalmología) y Ramsay Hunt (parálisis facial + otalgia + vesículas en concha: valaciclovir 7–10 días + prednisona).
- Neuralgia postherpética (dolor >3 meses): pregabalina o gabapentina, amitriptilina, lidocaína tópica.
- Seguimiento completo: control de dolor y lesiones; en inmunosuprimidos o diseminado, hospitalizar con aciclovir EV y aislamiento.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 5

Una mujer de 64 años consulta por dolor intercostal intenso de 3 semanas de evolución, que fue antecedido por la aparición de lesiones vesiculares en esa zona. En el examen físico se observa curación de las lesiones, algunas de las cuales dejaron cicatrices, sin otras alteraciones. **¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo del dolor?**

A) Pregabalina
B) Galantamina
C) Amitriptilina
D) Carbamazepina
E) Fluoxetina

Respuesta A. Dolor persistente en un dermatomo tras un herpes zóster ya cicatrizado es una neuralgia postherpética. El tratamiento de primera línea es pregabalina o gabapentina; la amitriptilina y la carbamazepina, antes de primera línea, hoy son de segunda línea.

Pregunta de práctica

Un paciente de 60 años consulta en urgencia por desviación de la comisura bucal hacia la derecha y dificultad para pronunciar las palabras desde hace 2 horas. Al examen físico se aprecia incapacidad para elevar la comisura labial izquierda; sin embargo, el paciente arruga la frente de forma perfectamente simétrica y ocluye ambos ojos con fuerza normal sin lagoftalmos. **¿Cuál es la localización topográfica más probable de la lesión y la conducta inmediata?**

A) Lesión del nervio facial periférico izquierdo en el foramen estilomastoideo; indicar prednisona oral ambulatoria
B) Lesión corticonuclear o hemisférica cerebral derecha (parálisis facial central); activar código de sospecha de ACV y solicitar TAC de cerebro de urgencia
C) Síndrome de Ramsay Hunt atípico; iniciar valaciclovir oral en altas dosis
D) Parálisis de Bell de curso frustro; indicar reposo y control ambulatorio en una semana
E) Otitis media aguda complicada con compresión del canal de Falopio; solicitar TAC de peñasco

Respuesta B. La frente está respetada y no hay lagoftalmos: es una parálisis facial central. Por la doble inervación corticonuclear de la frente, una lesión hemisférica unilateral la respeta. Requiere código ACV y TAC de cerebro urgente. Tratarla como Bell con corticoides ambulatorios es un error grave.

1.10.1.010 Lumbago mecánico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbago mecánico: la gran mayoría de los dolores lumbares; empeora con el movimiento y mejora con el reposo, sin irradiación bajo la rodilla ni déficit neurológico.
- Descartar banderas rojas: fiebre (espondilodiscitis), cáncer o baja de peso, dolor súbito en adulto mayor u osteoporosis (fractura), anestesia en silla de montar o retención urinaria (cauda equina), dolor que mejora con ejercicio en joven (espondilitis anquilosante).
- Sin banderas rojas no requiere imágenes (ni radiografía ni RM).

- Tratamiento: AINE en ciclos cortos (o paracetamol), mantener la actividad, evitar reposo prolongado, calor local y kinesioterapia; relajante muscular por pocos días si hay contractura.
- Educación: buen pronóstico, la mayoría mejora en 4–6 semanas; fortalecimiento de musculatura axial y abdominal para prevenir recurrencias.
- Seguimiento completo en APS: reevaluar a las 4–6 semanas; si persiste o aparecen banderas rojas, estudiar con imágenes y derivar.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 38 años, trabajador de bodega, presenta dolor lumbar de 4 días tras levantar una caja, sin irradiación bajo la rodilla. No tiene fiebre, baja de peso, alteración de esfínteres ni déficit neurológico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Resonancia magnética de columna lumbar
> **B)** Radiografía de columna lumbosacra y reposo absoluto por 2 semanas
> **C)** Derivación a neurocirugía
> **D)** Analgesia con AINE o paracetamol y mantener la actividad según tolerancia, sin imágenes
> **E)** Corticoides sistémicos en dosis altas
> Respuesta D. El lumbago mecánico agudo sin signos de alarma evoluciona favorablemente en 4 a 6 semanas. No requiere imágenes y se maneja con analgesia, calor local, educación y mantenerse activo, porque el reposo en cama retrasa la recuperación. Las imágenes se indican ante banderas rojas o persistencia mayor de 6 semanas.

1.10.1.011 Lumbociáticas y cervicobraquialgias.

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbociática: dolor lumbar irradiado bajo la rodilla por compresión radicular (hernia L4-L5 o L5-S1); Lasègue positivo. Cervicobraquialgia: dolor cervical irradiado al brazo, Spurling positivo.
- Precisar la raíz: L5 debilidad de dorsiflexión del ortejo mayor; S1 aquiliano disminuido y debilidad de flexión plantar; C6–C7 en el brazo.
- Banderas rojas: déficit motor progresivo, cauda equina (anestesia en silla de montar, retención urinaria) = RM y derivación urgente.
- Sin déficit: manejo igual al lumbago (AINE, actividad, kinesioterapia), puede sumarse analgésico para dolor neuropático; la mayoría mejora en 6 semanas.
- RM solo si hay banderas rojas, déficit o falla del tratamiento a las 6 semanas.
- Seguimiento: derivar a traumatología o neurocirugía si hay déficit agudo o fracaso médico (indicaciones de cirugía de la hernia).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 45 años con dolor lumbar irradiado por la cara posterior del muslo y la pierna hasta la planta y el borde lateral del pie. Al examen presenta Lasègue positivo a 40°, hipoestesia del borde lateral del pie, debilidad de la flexión plantar y reflejo aquiliano disminuido. **¿Cuál es la raíz más probablemente comprometida?**
> **A)** L3
> **B)** S1
> **C)** L5
> **D)** L4
> **E)** S3
> Respuesta B. La radiculopatía S1, típicamente por hernia discal L5-S1, produce dolor hacia la planta y el borde lateral del pie, debilidad de la flexión plantar y reflejo aquiliano disminuido. L5 compromete el dorso del pie y la extensión del ortejo mayor, sin alterar los reflejos clásicos, y L4 se asocia a reflejo rotuliano disminuido.

1.10.1.012 Migraña

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Migraña sin aura (IHS): ≥5 crisis de 4–72 h con 2 de 4 (unilateral, pulsátil, moderada-severa, empeora con actividad) + náuseas/vómitos o fotofobia y fonofobia.
- Migraña con aura: síntomas focales reversibles de 5–60 min (visuales en >90%, escotoma centellante; sensitivos de marcha cheiro-oral) seguidos de cefalea en <60 min.
- Diagnóstico clínico; buscar banderas rojas (SNOOP10) antes de rotular: si no hay, no se pide imagen.
- Crisis precoz: AINE en dosis plena + metoclopramida 10 mg; si es severa o falla, sumatriptán 50–100 mg VO o 6 mg SC. Triptán contraindicado en coronarios, ACV previo, HTA severa y migraña hemipléjica.
- Profilaxis si ≥3 crisis/mes o discapacidad: propranolol 40–160 mg (no en asma), amitriptilina, flunarizina o topiramato; valproato proscrito en mujer fértil.
- Seguimiento completo: diario de cefalea; analgésicos <15 días/mes y triptán <10 días/mes para evitar cefalea por abuso de medicación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años, abogada, sin antecedentes mórbidos. Hace 3 años presenta 4 a 5 crisis al mes de cefalea hemicránea derecha pulsátil, que empeora al caminar, con fotofobia, fonofobia y náuseas, de 24 a 36 horas de duración. Paracetamol y ketorolaco le dan alivio parcial y ha faltado varias veces al trabajo. Examen neurológico y fondo de ojo normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar TAC de encéfalo con contraste
B) Sumatriptán diario como tratamiento preventivo
C) Sumatriptán más antiemético en las crisis y propranolol como profilaxis
D) Ketorolaco diario hasta completar 3 meses sin crisis
E) Ácido valproico como profilaxis y paracetamol en las crisis

Respuesta C. Migraña sin aura (unilateral, pulsátil, empeora con la actividad, fotofobia + fonofobia + náuseas, 24–36 h) sin banderas rojas: no requiere imagen. Tiene 4–5 crisis al mes con falla de analgésicos: triptán más antiemético en la crisis y profilaxis de primera línea (propranolol si no tiene asma). El sumatriptán no es preventivo, el AINE diario causa cefalea por abuso de medicación y el valproato está proscrito en mujer en edad fértil.

1.10.1.013 Neuralgia esencial del trigémino

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.7 Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Neuralgia del trigémino: dolor lancinante como choque eléctrico, de segundos a 2 minutos, en V2–V3 (mejilla, maxilar, mandíbula), unilateral, típico en mayores de 50 años.
- Sello: zonas gatillo (lavarse la cara, afeitarse, cepillarse, masticar, brisa); asintomático entre crisis, sin síntomas autonómicos.
- Sospechar causa secundaria si compromete solo V1, es bilateral, en joven o con déficit sensitivo: esclerosis múltiple o tumor del ángulo pontocerebeloso (RM).
- Tratamiento de elección: carbamazepina 200–1.200 mg/día (alivia >80%); controlar hemograma y natremia. Alternativa oxcarbazepina; segunda línea baclofeno, lamotrigina, gabapentina.
- Diferencial: cefalea en racimos (15–180 min, orbitaria, lagrimeo y rinorrea, hombre fumador: oxígeno 100% + sumatriptán SC).
- Seguimiento: derivar a neurología; si es refractaria, neurocirugía (descompresión microvascular de Jannetta).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 25

Un paciente de 37 años consulta por dolor en la mandíbula inferior de segundos de duración, muy intenso, EVA 9/10, que se gatilla al comer y al lavarse los dientes. El dolor se ubica en la mitad izquierda de la mandíbula y en la arcada dental inferior izquierda. El examen físico no aporta mayor información. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neuralgia del trigémino
B) Cefalea cluster
C) Jaqueca clásica
D) Jaqueca complicada
E) Disfunción de la articulación temporomandibular

Respuesta A. Dolor de segundos, muy intenso, en el territorio mandibular (V3), gatillado al comer y lavarse los dientes: neuralgia del trigémino. La disfunción temporomandibular da dolor sordo y mantenido al masticar, sin paroxismos eléctricos gatillados por el roce.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 28

Una paciente de 55 años consulta por dolor facial de 3 meses de evolución, de carácter lancinante, que afecta la mejilla y el ala nasal derechas, además del labio superior y la arcada dental del lado derecho. El dolor es muy intenso y se desencadena ante acciones como tocarse la cara, lavarse los dientes y comer, en incluso por una brisa suave. El dolor dura solo unos pocos segundos, sin embargo, su intensidad es muy alta, con EVA 10/10. **¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?**

A) Pregabalina
B) Amitriptilina
C) Venlafaxina
D) Carbamazepina
E) Tramadol

Respuesta D. Neuralgia del trigémino clásica en V2 (mejilla, ala nasal, labio superior, arcada superior), gatillada por el roce y la brisa. El fármaco de elección es la carbamazepina. La pregabalina es de primera línea en la neuralgia postherpética, no en la del trigémino.

Pregunta de práctica

¿Cuál de las siguientes asociaciones entre cuadro clínico y patología es INCORRECTA? **Seleccione la asociación incorrecta:**

A) Cefalea temporoccipital, recurrente, opresiva – Cefalea tensional
B) Cefalea hemicránea, pulsátil, recurrente – Jaqueca
C) Cefalea progresiva, matinal, con signos focales – Tumor cerebral
D) Dolor neurálgico en la mejilla, muy intenso, de segundos de duración – Cluster
E) Cefalea muy intensa, de inicio súbito – Hemorragia subaracnoídea

Respuesta D. Un dolor neurálgico en la mejilla, de segundos, es neuralgia del trigémino (V2). El cluster es periorbitario, dura 15 a 180 minutos y se acompaña de síntomas autonómicos ipsilaterales. Las demás asociaciones son correctas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 94 · texto original del banco, sin revisar

Paciente mujer de 74 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo "eléctrico" lascinante en la mejilla y ala nasal izquierda, que compromete la arcada dentaria superior y la encía, así como la zona maxilar superior del lado izquierdo. Además presenta dolor retro ocular izquierdo. El dolor es de escasos segundos, pero intenso EVA 10/10, que se al tacto y al realizar actividades, como cepillarse los dientes e incluso una suave brisa puede desencadenarlo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este cuadro?

A) Pregabalina
B) Tramadol
C) Prednisona
D) Paracetamol y AINEs
E) Amoxicilina

Respuesta A. Es una neuralgia del trigémino (dolor eléctrico, de segundos, desencadenado por estímulos leves en territorio V2). El tratamiento de primera línea es carbamazepina; entre las alternativas, el anticonvulsivante útil es la pregabalina. El paracetamol y los AINEs no controlan el dolor neuropático, la prednisona no tiene rol y la amoxicilina no corresponde, pues no es un cuadro dental infeccioso.

1.10.1.014 Neuropatías por atrapamiento

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.19 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Túnel carpiano (mediano): parestesias nocturnas del pulgar a la mitad del anular que alivian al sacudir la mano (Flick); Phalen y Tinel positivos. Factores: mujer, embarazo, diabetes, hipotiroidismo, artritis reumatoide.
- Atrofia tenar o debilidad indican severidad. Confirmar con electromiografía y velocidad de conducción.
- Leve a moderado: férula nocturna con muñeca neutra 4–8 semanas, modificar actividades, infiltración con corticoide; severo o refractario: liberación quirúrgica.
- Ulnar (codo o canal de Guyon): 5° dedo y mitad del 4°, Froment, atrofia hipotenar y garra.
- Peroneo común en el cuello de la fíbula: pie caído con estepaje tras cruzar las piernas, yeso apretado o encamamiento; pierde dorsiflexión y eversión, conserva flexión plantar e inversión.
- Seguimiento: no requiere control especial si responde; derivar si hay déficit motor o atrofia.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 97

Paciente con parestesias nocturnas en una mano que ceden al sacudir las manos. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Neuropatía cubital
B) Síndrome de Raynaud
C) Síndrome del túnel carpiano
D) Radiculopatía C6
E) Polineuropatía diabética

Respuesta C. Parestesias nocturnas que ceden al sacudir la mano (signo de Flick): síndrome del túnel carpiano.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 126

Paciente embarazada de 26 semanas, bien controlada, consulta por cuadro de una semana de sensación de hormigueo en ambas manos de predominio nocturno, mayor en lado derecho, sin otros síntomas. Al examen físico destaca parestesia en ambas manos al mantener muñecas flexionadas por 20 segundos. **El diagnóstico más probable:**

A) Mielopatía cervical
B) Polimiositis
C) Miastenia gravis
D) Atrapamiento del nervio cubital
E) Atrapamiento del nervio mediano

Respuesta E. Embarazada con parestesias nocturnas en las manos y signo de Phalen positivo: túnel carpiano, es decir, atrapamiento del nervio mediano.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 111

Un paciente de 55 años con diabetes mellitus mal controlada con metformina consulta por disestesias y sensación de aumento de volumen o edema en ambas manos, de predominio nocturno, que disminuyen con el movimiento y ceden al iniciar sus actividades diarias. El examen físico muestra movilidad y sensibilidad conservadas, con leve atrofia de la eminencia tenar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neuropatía diabética simétrica sensitiva
B) Contractura de Dupuytren
C) Atrapamiento de los dedos flexores de la mano
D) Artritis reumatoide
E) Síndrome del túnel carpiano

Respuesta E. Síntomas nocturnos en las manos que ceden con el movimiento y atrofia tenar, en un diabético: túnel carpiano. La neuropatía diabética parte por los pies.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 30

Un paciente de 65 años, alcohólico inveterado, se queda dormido sobre el costado derecho, mientras estaba borracho. Al despertar, al día siguiente, no puede mover la mano derecha. Al examen neurológico, no puede extender los dedos ni la muñeca, aunque puede flectarlos sin problemas. Además no tiene alteraciones visuales ni afasia. **El diagnóstico más probable es:**

A) Hematoma subdural izquierdo
B) Trombosis de la vena subclavia
C) Neuropatía compresiva del nervio radial
D) Trombosis de la arteria subclavia
E) Hematoma capsular izquierdo

Respuesta C. Es una presentación clásica de neuropatía compresiva del nervio radial, la llamada parálisis del borracho.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 58 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 63 años, diabético mal controlado, presenta parestesias, asociada a dolor en ambas manos, que es mayor en la noche y que se irradia a ambos codos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polineuropatía diabética
B) Hernia del núcleo pulposo
C) Síndrome de túnel carpiano
D) Síndrome de atrapamiento cubital
E) Neuropatía radial

Respuesta C. Parestesias y dolor nocturno bilateral en las manos en un diabético mal controlado son más compatibles con un síndrome de túnel carpiano bilateral, frecuente en la diabetes, cuyo dolor puede irradiarse hacia el antebrazo y el codo. El atrapamiento cubital produce síntomas en el cuarto y quinto dedos y suele ser unilateral, y la polineuropatía diabética afecta primero los pies. La radiculopatía por

1.10.1.015 Parálisis (tetraparesia, hemiparesia, etc)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Localizar la lesión según el patrón: hemiparesia (hemisferio o tronco contralateral), paraparesia (médula), tetraparesia (médula cervical, tronco o nervio periférico/placa), monoparesia (corteza o nervio).
- Primera motoneurona: espasticidad, hiperreflexia y Babinski (en agudo puede haber flacidez por shock). Segunda motoneurona: flacidez, arreflexia, atrofia y fasciculaciones.
- Nivel sensitivo y trastorno esfinteriano = lesión medular: RM urgente (compresión neoplásica: dexametasona antes de la RM).
- Hemiparesia súbita = ACV: código ACV y TAC sin contraste. Tetraparesia ascendente arrefléctica = Guillain-Barré; con reflejos vivos, pensar en médula.
- Debilidad fluctuante y fatigable con pupilas normales = miastenia; proximal simétrica con CK alta = miopatía; con hipokalemia, parálisis periódica.
- No requiere seguimiento por el médico general: estabilizar y derivar según la causa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 57

Un hombre de 58 años presenta un cuadro de 3 años de evolución de debilidad progresiva de las extremidades que le dificulta caminar, hasta no poder hacerlo, a lo que luego se agrega dificultad para tragar. Evoluciona finalmente con dificultad respiratoria y necesidad de traqueostomía. No tiene alteración sensitiva. La espirometría muestra un patrón restrictivo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Polineuropatía diabética
B) Distrofia muscular
C) Esclerosis múltiple
D) Miastenia gravis
E) Esclerosis lateral amiotrófica

Respuesta E. Debilidad progresiva de extremidades con compromiso bulbar (disfagia) y respiratorio, sin alteración sensitiva, en un adulto, sugiere esclerosis lateral amiotrófica, con signos de primera y segunda motoneurona. La espirometría restrictiva refleja la debilidad diafragmática. La polineuropatía diabética es predominantemente sensitiva y la miastenia es fluctuante y fatigable.

1.10.1.016 Parálisis facial periférica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.19 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento · Tema 14.8 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt

QUÉ HAY QUE SABER

- Periférica: compromete toda la hemicara del mismo lado (no arruga la frente, lagoftalmos con signo de Bell, comisura caída). Central: respeta frente y cierre ocular, con hemiparesia = ACV, TAC urgente.
- Bell (idiopática, 60–75%): instalación en 1–2 días, dolor retroauricular previo, hiperacusia y ageusia de 2/3 anteriores.

- Tratamiento: prednisona 60 mg/día (1 mg/kg) por 7 días con descenso, idealmente antes de 72 h; antivirales no de rutina.
- Protección ocular obligatoria: lágrimas artificiales cada 1–2 h, ungüento y oclusión nocturna (riesgo de queratitis por exposición).
- Ramsay Hunt (vesículas en concha o conducto, otalgia, puede haber hipoacusia o vértigo): prednisona + valaciclovir 1 g c/8 h por 7–10 días; peor pronóstico.
- Seguimiento completo: >85% mejora en 3 semanas; derivar si es bilateral (pensar en Guillain-Barré), recurrente, con otros pares, masa parotídea o sin mejoría a los 3 meses.

PREGUNTAS (4)

Pregunta de práctica

Un paciente de 19 años consulta por imposibilidad de mover la mitad de la cara izquierda, que inició hace 3 horas. Presenta sensibilidad normal y conserva los movimientos masticatorios y oculomotores, sin embargo no es capaz de realizar movimientos con los músculos de expresión facial del lado izquierdo como sonreír, fruncir el ceño, arrugar la frente y tampoco puede cerrar completamente el ojo. El resto del examen neurológico es normal. **Además de la protección ocular la conducta más adecuada es:**

A) Iniciar carbamazepina
B) Iniciar clorpromazina
C) Iniciar amitriptilina
D) Iniciar aciclovir
E) Iniciar prednisona

Respuesta E. Parálisis facial periférica aguda (incluye la frente y el cierre ocular) sin otros hallazgos: parálisis de Bell. El tratamiento es prednisona precoz, dentro de las primeras 72 horas. El aciclovir no se recomienda de rutina.

Pregunta de práctica

Un paciente de 60 años consulta en urgencia por desviación de la comisura bucal hacia la derecha y dificultad para pronunciar las palabras desde hace 2 horas. Al examen físico se aprecia incapacidad para elevar la comisura labial izquierda; sin embargo, el paciente arruga la frente de forma perfectamente simétrica y ocluye ambos ojos con fuerza normal sin lagoftalmos. **¿Cuál es la localización topográfica más probable de la lesión y la conducta inmediata?**

A) Lesión del nervio facial periférico izquierdo en el foramen estilomastoideo; indicar prednisona oral ambulatoria
B) Lesión corticonuclear o hemisférica cerebral derecha (parálisis facial central); activar código de sospecha de ACV y solicitar TAC de cerebro de urgencia
C) Síndrome de Ramsay Hunt atípico; iniciar valaciclovir oral en altas dosis
D) Parálisis de Bell de curso frustro; indicar reposo y control ambulatorio en una semana
E) Otitis media aguda complicada con compresión del canal de Falopio; solicitar TAC de peñasco

Respuesta B. La frente está respetada y no hay lagoftalmos: es una parálisis facial central. Por la doble inervación corticonuclear de la frente, una lesión hemisférica unilateral la respeta. Requiere código ACV y TAC de cerebro urgente. Tratarla como Bell con corticoides ambulatorios es un error grave.

Pregunta de práctica

Una mujer de 38 años consulta por asimetría facial de instalación rápida en las últimas 24 horas. No puede cerrar el ojo derecho y al tomar líquidos se le escapan por la comisura derecha. Tiene borramiento de los pliegues de la frente derecha, con imposibilidad de arrugarla o levantar la ceja, lagoftalmos derecho y desviación de la comisura hacia la izquierda al sonreír. El resto del examen neurológico es normal. La otoscopía es normal y no hay vesículas. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Valaciclovir 1 g cada 8 horas, sin corticoides
B) Prednisona 1 mg/kg/día por 7 a 10 días, lágrimas artificiales y parche ocular nocturno
C) TAC de cerebro urgente y activar código ACV
D) Observación sin tratamiento por 2 semanas
E) Ciprofloxacino tópico en el oído

Respuesta B. No arruga la frente y tiene lagoftalmos: parálisis periférica. Sin vesículas ni otalgia, es una parálisis de Bell. Se trata con prednisona 1 mg/kg/día por 7 a 10 días dentro de las primeras 72 horas, más protección ocular. Los antivirales solos no sirven y el código ACV corresponde a la parálisis central.

Pregunta de práctica

Hombre de 22 años, sano, despierta con "la cara chueca". Ayer tuvo molestia retroauricular derecha. No eleva la ceja ni arruga la frente a derecha; al cerrar los ojos con fuerza el ojo derecho queda entreabierto 4 mm y el globo sube dejando ver la esclerótica. La comisura se desvía a la izquierda. Resto de pares, fuerza, sensibilidad y reflejos normales. Conducto auditivo sin vesículas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) TAC de encéfalo urgente y activar protocolo de ACV
B) Prednisona 60 mg/día por 7 días con descenso, más protección ocular
C) Aciclovir oral como tratamiento único
D) Prednisona más valaciclovir por Ramsay Hunt
E) Observar, porque más del 85% mejora solo

Respuesta B. Compromiso de toda la hemicara, incluida la frente, con lagoftalmos y signo de Bell y sin otros hallazgos: parálisis facial periférica idiopática (Bell). Se trata con prednisona precoz (<72 h) y protección ocular obligatoria. La TAC es para la parálisis central (frente preservada); el antiviral, para el Ramsay Hunt (vesículas).

1.10.1.017 Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc…

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Polineuropatía: distal, simétrica y largo-dependiente; parestesias y dolor urente en calcetín y guante, aquilianos disminuidos con rotulianos conservados.
- Causas: diabetes (la más frecuente), alcohol, déficit de B12, hipotiroidismo, ERC, VIH, fármacos (quimioterapia, isoniazida); pedir glicemia/HbA1c, B12, TSH, creatinina.
- Radiculopatía: dolor que sigue un dermatoma, con déficit en el miotoma y reflejo de esa raíz (hernia discal). Mononeuropatía: territorio de un nervio (túnel carpiano, peroneo, III par diabético).
- Polineuropatía aguda ascendente motora y arrefléctica = Guillain-Barré (urgencia).
- Manejo inicial: tratar la causa (control glicémico, B12, suspender alcohol), cuidado de pies con monofilamento en diabéticos, dolor neuropático con pregabalina, gabapentina o amitriptilina.
- No requiere seguimiento especial por el médico general salvo el de la causa; EMG con velocidad de conducción si hay duda diagnóstica.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 44

Un paciente diabético de larga data, mal controlado, en tratamiento con metformina y empaglifozina. Consulta por ptosis y molestias visuales en el ojo derecho. Al examen físico, tiene ptosis del ojo derecho, que se asocia a diplopía al abrir manualmente el párpado. Además, tiene dificultades en la aducción y elevación del ojo derecho. Su agudeza visual se constata como 20/25 bilateral. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Accidente vascular encefálico
B) Tumor cerebral
C) Cáncer de pulmón con compromiso del ganglio estrellado
D) Ptosis aponeurótica
E) Parálisis del tercer nervio craneal

Respuesta E. Ptosis con déficit de aducción y elevación de un solo ojo, en un diabético mal controlado: parálisis del III par (mononeuropatía diabética). A diferencia de la miastenia, el compromiso sigue el territorio de un solo nervio y no fluctúa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 59

Paciente de 70 años consulta por dolor tipo urente en las extremidades inferiores, asociado a parestesias descritas como hormigueos en los pies. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad en calcetín, con paresia a la extensión de los ortejos y disminución de ambos reflejos aquilianos. En cambio, los reflejos rotulianos se encuentran conservados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Radiculopatía S1 bilateral
B) Síndrome de cauda equina
C) Síndrome del cono medular
D) Síndrome de Guillain-Barré
E) Polineuropatía

Respuesta E. Dolor urente y parestesias distales, hipoestesia en calcetín, debilidad distal y aquilianos disminuidos con rotulianos conservados: compromiso distal, simétrico y largo-dependiente, típico de polineuropatía. La radiculopatía sigue un dermatoma; la cauda equina y el cono dan anestesia en silla de montar y trastornos esfinterianos; el Guillain-Barré es agudo, motor y ascendente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 23 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 69 años presenta debilidad de las manos, asociados a disminución de la sensibilidad de manos y pies. Refiere además dolor tipo ardor en las extremidades inferiores. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad "en calcetín", signo de Lasegue negativo y presenta abolición de ambos reflejos aquileanos. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Radiculopatía S1
C) Síndrome de cola de caballo
D) Polineuropatía
E) Esclerosis lateral amiotrófica

Respuesta D. Diagnóstico: Polineuropatía (opción D). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 119 · texto original del banco, sin revisar

Hombre de 55 años con diabetes mellitus de larga data. Presenta debilidad asimétrica en extremidades, afectando nervio peroneo derecho y cubital izquierdo. Sin compromiso de pares craneanos. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Mononeuritis múltiple
B) Polineuropatía diabética simétrica
C) Síndrome de Guillain-Barré
D) ACV múltiple
E) Miopatía inflamatoria

Respuesta A. Afectación de nervios periféricos individuales, no contiguos y asimétricos en diabético = mononeuritis múltiple (mononeuropatía múltiple). Causas: diabetes, vasculitis, lepra.

1.10.1.018 Síndrome atáxico

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.20 Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome atáxico cerebeloso: marcha de base amplia, dismetría (índice-nariz), disdiadococinesia, temblor de intención, nistagmo y disartria escandida; lesión hemisférica da signos ipsilaterales.
- Ataxia sensitiva (cordones posteriores): Romberg positivo, pérdida de vibración y posición (déficit de B12, tabes). Vestibular: vértigo, con lateropulsión.
- Agudo con vértigo, cefalea occipital e imposibilidad de pararse = ACV o hemorragia cerebelosa: TAC/RM urgente (hematoma ≥3 cm se opera por compresión de tronco e hidrocefalia).
- Otras causas: alcohol (degeneración vermiana), fármacos (fenitoína, litio), Wernicke (ataxia + oftalmoplejía + confusión: tiamina EV), esclerosis múltiple, tumores de fosa posterior, paraneoplásica, hereditarias.
- Manejo inicial: suspender tóxicos, tiamina en alcohólicos, corregir B12 y neuroimagen.
- No requiere seguimiento por el médico general: derivar a neurología.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años, hipertenso, presenta en forma súbita vértigo, vómitos, cefalea occipital e imposibilidad de mantenerse de pie. Al examen tiene dismetría en la prueba índice-nariz y disdiadococinesia derechas, marcha con lateralización a derecha y nistagmo que cambia de dirección con la mirada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Maniobra de Epley
B) Betahistina y control ambulatorio
C) Corticoides por neuronitis vestibular
D) Audiometría
E) Neuroimagen urgente (TAC o resonancia de cerebro) por sospecha de lesión cerebelosa

Respuesta E. Un síndrome atáxico agudo con dismetría y disdiadococinesia ipsilaterales, cefalea y nistagmo que cambia de dirección es de origen central: debe descartarse hemorragia o infarto cerebeloso con neuroimagen urgente, porque el edema puede comprimir el tronco y causar hidrocefalia, requiriendo cirugía. Epley y betahistina son para cuadros periféricos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 89 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 75 años, con antecedente de EPOC en tratamiento con broncodilatadores inhalados y bromhexina 8mg cada 8h, más consumo de alcohol de una botella de vino de 750 cc durante los fines de semana, consulta por dificultades para caminar y hablar de 3 meses de evolución, progresivas, asociadas a torpeza de las extremidades. No ha presentado náuseas ni cefalea. Al examen Fsico, se aprecia ataxia de la marcha, habla disártrica y dismetría de las extremidades superiores, con imposibilidad de realizar movimientos alternantes de forma coordinada. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Toxicidad cerebelosa por bromhexina
B) Degeneración cerebelosa alcohólica
C) Esclerosis múl2ple
D) Síndrome paraneoplásico
E) Tumor cerebeloso

Respuesta D. Pregunta muy difícil, aunque Gene un claro síndrome cerebeloso. Sin embargo, no queda clara la causa. Tiene factores de riesgo para cáncer pulmonar, que puede producir una cerebeliGs autoinmune, siendo compaGble el cuadro con la velocidad que se instauró. No Gene náuseas ni cefalea para pensar en un tumor. El consumo de alcohol no es muy grande y el daño cerebeloso por alcohol suele ser de instala

1.10.1.019 Síndrome de hipertensión endocraneana

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.5 Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena · Tema 15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertensión endocraneana: cefalea progresiva de predominio matinal que empeora con Valsalva y decúbito, vómitos (explosivos), oscurecimientos visuales y diplopía por VI par (falsa localización).
- Fondo de ojo: edema de papila bilateral (papilas solevantadas, bordes borrosos, sin pulso venoso, hemorragias peripapilares), con agudeza visual conservada al inicio.
- Signos de herniación: compromiso de conciencia, midriasis unilateral y tríada de Cushing (HTA, bradicardia, respiración irregular).
- Neuroimagen urgente antes de cualquier punción lumbar (riesgo de herniación): tumor, hematoma, hidrocefalia, absceso, trombosis venosa (angio-RM venosa); hipertensión intracraneal idiopática en mujer joven obesa.
- Medidas iniciales: cabecera a 30°, vía aérea, normoventilación, manitol o suero hipertónico; dexametasona si hay edema vasogénico por tumor; evitar sueros hipotónicos.
- No requiere seguimiento del médico general: derivar a neurocirugía o neurología según la causa.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 169

Una paciente de 45 años, con antecedente de hipertensión arterial y migraña tratada con antiinflamatorios y ergotamínicos, consulta por cefalea más intensa de lo habitual, desde hace dos meses, que inicialmente era mayor durante la mañana, pero que ha aumentado en intensidad durante todo el día y se ha asociado a náuseas y vómitos explosivos. Refiere no haber tenido respuesta a pesar del uso frecuente de analgésicos y ergotamínicos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de hipertensión endocraneana
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Encefalopatía hipertensiva
D) Tumor cerebral
E) Cefalea por ergotamínicos

Respuesta A. Una migrañosa con cambio de patrón: cefalea progresiva, de predominio matinal, con vómitos explosivos y sin respuesta al tratamiento habitual. Son banderas rojas (letra P de SNOOP10) de hipertensión endocraneana: fondo de ojo y neuroimagen. La cefalea por abuso de medicación no explica los vómitos explosivos ni el predominio matinal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 169

Paciente de 45 años, con antecedente de hipertensión arterial y migraña tratada con antiinflamatorios y ergotamínicos, consulta por cefalea más intensa de lo habitual desde hace 2 meses, que inicialmente predominaba en la mañana, pero que ha aumentado en intensidad durante todo el día y se ha asociado a náuseas y vómitos explosivos. Refiere no haber tenido respuesta a pesar del uso frecuente de analgésicos y ergotamínicos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de hipertensión endocraneana
B) Hemorragia subaracnoídea
C) Encefalopatía hipertensiva
D) Tumor cerebral
E) Cefalea por ergotamínicos

Respuesta A. Cefalea progresiva de predominio matinal, con náuseas y vómitos explosivos y sin respuesta a analgésicos: síndrome de hipertensión endocraneana (cefalea matinal, vómitos y edema de papila). Obliga a fondo de ojo y neuroimagen. El tumor es una causa posible, pero el diagnóstico sindromático es la HTEC; la hemorragia subaracnoídea es súbita, no de 2 meses.

1.10.1.020 Síndrome miasténico

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.17 Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

QUÉ HAY QUE SABER

- Miastenia gravis: debilidad fatigable (peor con el uso y en la tarde, mejora con reposo); ptosis asimétrica y diplopía que no calzan con un par, voz nasal, fatiga al masticar, debilidad proximal.
- Pupilas siempre normales: ptosis con midriasis descarta miastenia (pensar en III par por aneurisma, botulismo). Reflejos y sensibilidad normales.
- Pruebas de cabecera: test del hielo (mejora ≥2 mm) y Simpson; confirmar con anticuerpos anti-receptor de ACh (si negativos, anti-MuSK) y estimulación repetitiva (decremento >10%).
- TAC de tórax obligatorio en todos (timoma 10–15%). Tratamiento sintomático con piridostigmina 30–60 mg c/4–6 h.
- Evitar fármacos que la descompensan: aminoglucósidos, quinolonas, macrólidos, betabloqueadores, sulfato de magnesio EV.
- Crisis miasténica (falla respiratoria, disfagia grave): UCI, intubación precoz, plasmaféresis o inmunoglobulina. Seguimiento por neurología.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 74

Una paciente de 38 años, profesora de enseñanza básica, consulta por debilidad y mialgias generalizadas, que iniciaron hace 1 mes. Además, refiere ptosis a derecha, que suele ser mayor en las tardes. Al examen físico se constata ptosis bilateral, mayor a derecha, con normalidad de los reflejos osteotendíneos y la sensibilidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esclerosis lateral amiotrófica
B) Polimiositis
C) Síndrome de Guillain Barré
D) Esclerosis múltiple
E) Miastenia gravis

Respuesta E. Ptosis fluctuante, que empeora con el uso y en la tarde, con reflejos y sensibilidad normales: es el cuadro clásico de miastenia gravis, una falla de la placa neuromuscular. Y aquí conecta con el mediastino: frente a una miastenia gravis hay que buscar un timoma, con TAC de tórax con contraste.

Pregunta de práctica

Mujer de 29 años, cajera, con 3 semanas de ptosis y diplopía que aparecen al avanzar la jornada; amanece casi asintomática. Se le cansa la mandíbula al masticar y la voz se vuelve gangosa en la tarde. Ptosis bilateral de predominio izquierdo, pupilas isocóricas y reactivas. El test del hielo mejora la hendidura palpebral 3,5 mm. Reflejos y sensibilidad normales. **Además de iniciar piridostigmina, ¿qué estudio es obligatorio solicitar?**

A) Angiografía cerebral por sospecha de aneurisma de comunicante posterior
B) Punción lumbar para buscar disociación albúmino-citológica
C) Anticuerpos anti-receptor de acetilcolina y TAC de tórax con contraste
D) Resonancia magnética de cerebro con gadolinio
E) Creatinquinasa y biopsia muscular

Respuesta C. Fatigabilidad vespertina ocular y bulbar, pupilas normales y test del hielo positivo: miastenia gravis. Se confirma con anti-AChR (y anti-MuSK si es negativo) y electromiografía con estimulación repetitiva, y la TAC de tórax es obligatoria en todos para buscar timoma. Con pupilas normales no se sospecha aneurisma; la punción lumbar es para Guillain-Barré.

1.10.1.021 Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 9.13 Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome miopático: debilidad proximal y simétrica de cinturas (dificultad para levantarse, subir escaleras, peinarse), con sensibilidad y reflejos conservados y sin compromiso ocular.
- Dermatomiositis: heliotropo y pápulas de Gottron; polimiositis sin piel. CK 10–50 veces lo normal; complicaciones: enfermedad pulmonar intersticial (anti-Jo1), disfagia y miocarditis.
- En adultos (sobre todo >50 años) tamizar cáncer oculto (25–30%): TAC de tórax-abdomen-pelvis, mamografía, ecografía transvaginal, endoscopías.
- Distrofias musculares: hereditarias, inicio en la infancia (Duchenne: varón, Gowers, pseudohipertrofia de pantorrillas, CK muy alta).
- Descartar causas tóxicas y metabólicas: estatinas (medir CK), hipotiroidismo (TSH), corticoides, alcohol, hipokalemia.
- Confirmación con EMG, RM muscular y biopsia (patrón oro); no requiere seguimiento por el médico general: derivar a reumatología o neurología.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM 2019 · Pregunta 15

¿Cuál de las siguientes características anatomopatológicas e inmunohistoquímicas es típica de la biopsia muscular en una POLIMIOSITIS, permitiendo diferenciarla de la dermatomiositis?

A) Atrofia perifascicular prominente con depósito vascular de complemento C5b-9
B) Infiltrado inflamatorio endomisial compuesto por linfocitos T citotóxicos CD8+ que invaden miofibras
C) Infiltración exclusiva de eosinófilos con vasculitis necrotizante transmural
D) Depósito masivo de sustancia amiloide rojo Congo positiva en el endomisio
E) Ausencia total de células inflamatorias con degeneración grasa aislada

Respuesta B. En la polimiositis el mecanismo inmune es una citotoxicidad celular directa mediada por linfocitos T CD8+ que infiltran el endomisio e invaden activamente miofibras no necróticas que sobreexpresan antígenos HLA clase I. En cambio, la dermatomiositis es una microangiopatía mediada por complemento/anticuerpos que produce atrofia perifascicular e infiltrado perimisial por linfocitos CD4+ y B.

Pregunta real · EUNACOM 2024 · Pregunta 20

¿Cuál de los siguientes grupos musculares se encuentra característicamente RESPETADO en la polimiositis y dermatomiositis, orientando el diagnóstico hacia Miastenia Gravis si se encuentra afectado?

A) Músculos deltoides y supraespinoso
B) Músculos psoas ilíaco y cuádriceps femoral
C) Músculos flexores profundos del cuello
D) Músculos extraoculares y palpebrales intrínsecos
E) Músculos constrictores de la faringe

Respuesta D. Las miopatías inflamatorias autoinmunes afectan típicamente la musculatura estriada proximal de las cinturas escapular y pelviana, flexores del cuello y faringe, pero RESPETAN de forma estricta los músculos extraoculares y la musculatura facial. La presencia de ptosis palpebral fluctuante o diplopía es característica de la Miastenia Gravis, no de la polimiositis ni dermatomiositis.

1.10.1.022 Síndromes convulsivos sintomáticos (traumático, tumores SNC, metabólico, etc)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis sintomática aguda (provocada): ocurre en relación temporal con una noxa aguda; no es epilepsia y no requiere antiepiléptico crónico.
- Causas metabólicas: hipoglicemia (<50 mg/dL; glibenclamida, insulina), hiponatremia (<120 o rápida), hipocalcemia, uremia, encefalopatía hepática.
- Tóxicas y estructurales agudas: abstinencia alcohólica (24–48 h), cocaína, meningitis o encefalitis, TEC, ACV, tumor o neurocisticercosis (lesión quística con eosinófilos en LCR).
- Estudio en toda primera crisis: glicemia capilar inmediata, electrolitos (Na, K, Ca, Mg), función renal y hepática, tóxicos, ECG y TAC sin contraste; RM ambulatoria.
- Tratar la causa: glucosa (con tiamina previa en alcohólicos), corregir sodio lentamente, benzodiacepinas en abstinencia; si la crisis dura ≥5 min, protocolo de estatus.
- Seguimiento: derivar a neurología si hay lesión estructural (tumor, secuela de TEC) que dé riesgo de epilepsia; indicar no conducir mientras se estudia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años, diabético usuario de insulina, presenta una crisis tónico-clónica generalizada en su casa. Al llegar el SAMU tiene glicemia capilar de 28 mg/dL; se administra glucosa endovenosa y recupera completamente la conciencia. Examen neurológico normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la crisis?**

A) Iniciar ácido valproico de mantención
B) Diagnosticar epilepsia del adulto
C) Iniciar levetiracetam por al menos 2 años
D) Resonancia y electroencefalograma antes de reiniciar la insulina
E) Corregir la causa y ajustar el tratamiento de la diabetes, sin fármaco antiepiléptico crónico

Respuesta E. Una crisis desencadenada por una alteración metabólica aguda (hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, abstinencia alcohólica) es una crisis sintomática aguda, no epilepsia. Se trata corrigiendo la causa y previniendo que se repita; no requiere antiepiléptico de mantención, porque el riesgo de recurrencia depende de la causa.

1.10.1.023 Síndromes sensitivos (polineuropatía, hemihipoestesia, dolor talámico, etc)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 8.6 Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

QUÉ HAY QUE SABER

- Localizar por el patrón sensitivo: polineuropatía en guante y calcetín (diabetes, alcohol, B12), radicular por dermatoma, nivel sensitivo en el tronco (médula), hemihipoestesia (tálamo o corteza contralateral).
- Déficit de B12: degeneración combinada subaguda con pérdida de vibración y posición, Romberg positivo, ataxia y signos piramidales, más parestesias distales; causas: anemia perniciosa, gastrectomía, metformina o IBP prolongados.
- Disociación sensitiva: termoalgésica con tacto conservado (siringomielia, en capa), síndrome de Brown-Séquard (propioceptiva ipsilateral y termoalgésica contralateral).
- Dolor talámico (Dejerine-Roussy): dolor urente contralateral tras un infarto talámico; tratar con amitriptilina, gabapentina o pregabalina.
- Manejo inicial: B12 sérica, glicemia, TSH; B12 1.000 μg IM diario por 7 días, luego semanal y mensual de por vida en malabsorción; nunca ácido fólico solo (empeora lo neurológico).
- Hemihipoestesia súbita = ACV (código ACV); nivel sensitivo agudo = RM urgente. Sin seguimiento especial del médico general salvo la causa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 66 años, vegana estricta desde hace 15 años y usuaria de metformina, consulta por hormigueo en pies y manos e inestabilidad al caminar en la oscuridad. Al examen tiene pérdida de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva en extremidades inferiores, Romberg positivo y reflejos aquilianos disminuidos. Hemoglobina 11,2 g/dL, VCM 104 fL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Polineuropatía diabética
B) Degeneración combinada subaguda por déficit de vitamina B12
C) Ataxia cerebelosa alcohólica
D) Síndrome de Guillain-Barré
E) Esclerosis múltiple

Respuesta B. Compromiso de cordones posteriores (pérdida vibratoria y propioceptiva, Romberg positivo, ataxia sensitiva) con macrocitosis en una vegana usuaria de metformina sugiere déficit de vitamina B12. Se confirma con niveles de B12 y ácido metilmalónico y se trata con B12 parenteral. La polineuropatía diabética no explica la macrocitosis, y la ataxia cerebelosa tiene Romberg negativo.

1.10.1.024 Síndromes vertiginosos centrales

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.20 Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS

QUÉ HAY QUE SABER

- Vértigo central (urgencia vital): no puede mantenerse de pie, ataxia desproporcionada, focalidad de tronco o cerebelo (diplopía, disartria, disfagia, dismetría), nistagmo vertical o que cambia de dirección y no se inhibe al

fijar la mirada.

- En el síndrome vestibular agudo (vértigo continuo de días) aplicar HINTS: impulso cefálico normal, nistagmo que cambia de dirección o skew positivo = central; basta un signo.
- La TAC detecta <15–20% de los infartos de fosa posterior y la RM con difusión tiene falsos negativos en las primeras 24–48 h: una imagen normal no descarta ACV.
- Causas: infarto o hemorragia cerebelosa o de tronco (PICA, AICA), esclerosis múltiple, tumores de fosa posterior, migraña vestibular.
- Conducta: código ACV, hospitalizar en UTAC (GES), angio-RM urgente; hematoma cerebeloso ≥3 cm es indicación quirúrgica.
- No requiere seguimiento del médico general: derivar a neurología.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 29

Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento, consulta por vértigo intenso de inicio súbito hace 2 horas, asociado a dificultades en la marcha que le impiden mantenerse de pie. Al examen físico se observa hipotónico, con dismetría de extremidades y nistagmus multidireccional. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar difenidol
B) Realizar examen de VIII par
C) Solicitar prueba calórica
D) Solicitar resonancia magnética nuclear de troncoencéfalo
E) Solicitar TAC de cerebro

Respuesta E. Vértigo central: súbito, con incapacidad para la bipedestación, dismetría y nistagmo multidireccional en un hipertenso. La primera sospecha es un ACV cerebeloso o vertebrobasilar, y lo urgente es la TAC de cerebro: rápida, detecta la hemorragia (que, si es cerebelosa ≥ 3 cm, se opera) y, si no hay sangre, permite evaluar trombólisis. La resonancia ve mejor la fosa posterior, pero viene después.

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años, hipertenso y diabético, con vértigo continuo desde hace 10 horas, vómitos e inestabilidad. No puede mantenerse de pie sin apoyo. Sin hipoacusia. Impulso cefálico sin sacada correctiva hacia ambos lados; nistagmo horizontal que bate a la derecha al mirar a la derecha y a la izquierda al mirar a la izquierda. TAC de encéfalo sin contraste normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dimenhidrinato EV y alta con control, porque la TAC es normal
B) Maniobra de Epley
C) Activar código ACV, hospitalizar en UTAC y angio-RM urgente
D) Betahistina 24 mg c/12 h y restricción de sal
E) Sedantes vestibulares por 3 semanas y rehabilitación vestibular

Respuesta C. Síndrome vestibular agudo en un paciente vascular con HINTS central: impulso cefálico normal y nistagmo que cambia de dirección, más incapacidad de mantenerse de pie. La TAC normal no descarta un infarto de fosa posterior: se activa el código ACV, se hospitaliza en UTAC (GES 37) y se pide angio-RM urgente.

1.10.1.025 Síndromes vertiginosos periféricos

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.20 Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS · Tema 14.7 Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

QUÉ HAY QUE SABER

- Periférico: brusco, intenso, con muchos vómitos, camina aunque se ladee, nistagmo horizontal-rotatorio unidireccional que se inhibe al fijar la mirada; puede tener síntomas auditivos.
- VPPB (el más frecuente): episodios de segundos al girar en la cama o mirar arriba; Dix-Hallpike con latencia, nistagmo torsional y fatigable; tratar con maniobra de Epley (cura >80–90%), sin fármacos ni imágenes.
- Neuronitis vestibular: vértigo continuo de días, sin hipoacusia; sedantes vestibulares (dimenhidrinato 50 mg c/8 h) solo 48–72 h y prednisona precoz.
- Menière: crisis de 20 min a 12 h con hipoacusia fluctuante de tonos graves, tinnitus y plenitud ótica; sal <2 g/día, diurético y betahistina 24 mg c/12 h.
- Siempre aplicar HINTS en el vértigo continuo: impulso cefálico normal, nistagmo que cambia de dirección o skew = central (código ACV).

- Seguimiento completo: rehabilitación vestibular, evitar sedantes prolongados; audiometría en Menière y derivar a ORL si recurrente o refractario.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un hombre de 38 años consulta en urgencia por vértigo rotatorio continuo de 24 horas, con náuseas y múltiples vómitos, que le impide caminar. Una semana antes tuvo un resfrío. No tiene hipoacusia ni acúfenos. Presenta nistagmo horizontal unidireccional hacia la derecha, que aumenta al mirar a la derecha, impulso cefálico anormal con sacada correctiva hacia la izquierda y test de skew negativo. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Maniobra de Epley en la consulta
B) Dimenhidrinato por 48 horas y prednisona 1 mg/kg/día por 7 días
C) Dieta con sodio menor de 2 g/día e hidroclorotiazida
D) Sedantes vestibulares por 4 semanas para evitar recurrencias
E) Hospitalizar por sospecha de ACV de fosa posterior

Respuesta B. Es una neuronitis vestibular, con HINTS periférico: impulso cefálico anormal, nistagmo unidireccional horizontal y skew negativo. Se trata con antieméticos o sedantes vestibulares solo por 48 horas, para no frenar la compensación central, más prednisona 1 mg/kg/día por 7 días. Epley es para el VPPB y la dieta sin sal para Ménière.

Pregunta de práctica

Mujer de 57 años con 5 días de episodios de vértigo rotatorio intenso de menos de 1 minuto, que aparecen al darse vuelta en la cama o al mirar hacia arriba, con náuseas. Sin hipoacusia, tinnitus ni síntomas neurológicos. Examen neurológico normal. Maniobra de Dix-Hallpike derecha: tras una latencia de 5 segundos, nistagmo torsional geotrópico y vertical hacia arriba, que dura 20 segundos y se agota al repetirla. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Betahistina 24 mg cada 12 horas por 3 meses
B) Dimenhidrinato diario por 3 semanas
C) RM de encéfalo urgente
D) Prednisona oral por 10 días
E) Maniobra de reposición de Epley

Respuesta E. Vértigo posicional breve con Dix-Hallpike positivo (latencia, nistagmo torsional geotrópico, duración menor de 1 minuto y fatigable): vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior derecho. Se trata con la maniobra de reposición de Epley, efectiva en la mayoría con 1 o 2 sesiones. Los sedantes vestibulares retrasan la compensación; no requiere imagen.

1.10.1.026 Temblor esencial

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.13 Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Temblor esencial: el trastorno del movimiento más frecuente; postural y de acción (sopa, vaso, escritura), bilateral, 8–12 Hz, puede afectar cabeza (no-no) y voz.
- Claves: antecedente familiar (autosómico dominante), mejora con alcohol, examen neurológico normal sin bradicinesia ni rigidez; nunca temblor de pierna en reposo.
- Descartar temblor fisiológico exagerado: hipertiroidismo (TSH), cafeína, ansiedad, abstinencia alcohólica y fármacos (salbutamol, litio, valproato, levotiroxina en exceso).
- Diferencial con Parkinson: temblor de reposo asimétrico que cede al moverse, con bradicinesia y rigidez.
- Tratamiento inicial si afecta la vida diaria: propranolol 40–160 mg/día (contraindicado en asma, bloqueo AV, bradicardia); alternativa primidona 25–250 mg en la noche.
- No requiere seguimiento especial: ajustar dosis según respuesta; derivar si es refractario o atípico.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 161

Paciente masculino, de 71 años de edad, con un cuadro de 2 años de evolución de temblor de ambas extremidades superiores, lo cual le sucede al escribir, tomar un objeto, o al usar cubiertos. Toma alprazolam 0,5 mg/dl, dos veces por día por cuadro ansioso. Al examen físico no tiene temblor de reposo y se observan reflejos osteotendíneos conservados, con tono muscular y sensibilidad normal. El temblor se acentúa al tratar de tomar un objeto. **El diagnóstico más probable es:**

A) Hipertiroidismo
B) Enfermedad de Parkinson
C) Temblor esencial
D) Temblor por ansiedad
E) Temblor por medicamentos

Respuesta C. Temblor bilateral de acción de 2 años (al escribir, tomar objetos, usar cubiertos), sin temblor de reposo y con tono normal: temblor esencial. El alprazolam no causa temblor; más bien lo atenúa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 85

Un paciente de 72 años consulta por temblor ambas extremidades, que aparece al realizar sus actividades habituales. Al examen físico se observa el mencionado temblor, sin otras alteraciones en la exploración neurológica. **¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de sus síntomas?**

A) Diazepam
B) Alprazolam
C) Propranolol
D) Levodopa
E) Sertralina

Respuesta C. Temblor de acción bilateral con examen neurológico por lo demás normal: temblor esencial. El tratamiento de primera línea es propranolol (o primidona).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 147 · texto original del banco, sin revisar

Adulto mayor con temblor al escribir, un temblor esencial ¿Con que se trata? a. Propanolol

A) Accidente cerebrovascular
B) Epilepsia
C) Esclerosis múltiple
D) Enfermedad de Parkinson
E) Migraña

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Accidente cerebrovascular). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Epilepsia, Esclerosis múltiple) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

1.10.1.027 Trastornos del sueño

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.11 Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

QUÉ HAY QUE SABER

- Insomnio: el trastorno del sueño más frecuente; primero higiene del sueño y terapia cognitivo-conductual; buscar depresión, ansiedad, dolor, alcohol y cafeína. Benzodiacepinas solo por períodos cortos.
- Apnea obstructiva del sueño: ronquido, apneas presenciadas, somnolencia diurna, obesidad, HTA resistente; se estudia con polisomnografía y se trata con CPAP y baja de peso.
- Trastorno conductual del sueño REM: grita, golpea o patea actuando sus sueños (pérdida de la atonía del REM); se asocia a sinucleinopatías (Parkinson, Lewy) y puede precederlas por años.
- Parasomnias no REM (sonambulismo, terrores nocturnos): niños, sin recuerdo, benignas.
- Narcolepsia: somnolencia diurna excesiva con cataplejía, alucinaciones hipnagógicas y parálisis del sueño. Piernas inquietas: medir ferritina.
- Manejo inicial: medidas de higiene y tratar comorbilidades; derivar a neurología o centro de sueño para polisomnografía.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 98

Hombre de 65 años con antecedente de enfermedad de Parkinson. Su pareja refiere que durante el sueño emite gritos, golpea y patea. El paciente no recuerda nada al despertar. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Trastorno de conducta del sueño REM (RBD)
B) Sonambulismo
C) Terrores nocturnos
D) Apnea obstructiva del sueño
E) Epilepsia nocturna del lóbulo frontal

Respuesta A. Conducta violenta durante el sueño en un paciente con Parkinson: trastorno conductual del sueño REM. Se pierde la atonía del REM y el paciente actúa sus sueños. Es la parasomnia típica de las sinucleinopatías.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 122

Un paciente, durante el sueño, se levanta, grita y golpea. Al despertar refiere que soñaba que se defendía. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Sonambulismo
B) Terror nocturno (pavor nocturnus)
C) Trastorno conductual del sueño REM
D) Pesadillas recurrentes
E) Epilepsia nocturna del lóbulo frontal

Respuesta C. Conductas motoras violentas que representan el contenido de un sueño, con recuerdo onírico al despertar, son típicas del trastorno conductual del sueño REM, por pérdida de la atonía muscular propia de esa fase. Se asocia a sinucleinopatías como Parkinson y cuerpos de Lewy, y puede precederlas por años. Sonambulismo y terrores nocturnos ocurren en sueño no REM, sin recuerdo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 84 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 75 años ha presentado varios episodios durante el sueño, en los que tiene movimientos bruscos, actuando sus sueños, llegando incluso a golpear a su a su esposa en una oportunidad, mientras dormía. Cuando despertó comentó que estaba soñando que lo atacaban, por lo que se estaba defendiendo. Se muestra muy preocupado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sonambulismo
B) Epilepsia de lóbulo frontal
C) Enfermedad de Parkinson
D) Trastorno conductual del sueño REM
E) Síndrome confusional agudo

Respuesta E. Diagnóstico: Síndrome confusional agudo (opción E). Esta clase cubre los principales trastornos del sueño: insomnio, hipersomnia, síndrome de piernas inquietas, pesadillas y terrores nocturnos, y narcolepsia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

1.10.1.028 Tumores de región sellar

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.20 Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Masas selares: adenomas hipofisarios (prolactinoma 40%, no funcionante 30–35%), craneofaringioma (quístico, calcificado; niños y >50 años), meningioma, quiste de Rathke, apoplejía.
- Macroadenoma (≥10 mm) con extensión supraselar comprime el quiasma: hemianopsia bitemporal con visión central conservada y cefalea; invasión del seno cavernoso: III, IV, VI par.
- Clínica hormonal: hiperprolactinemia (amenorrea, galactorrea, disfunción sexual), acromegalia, Cushing, o hipopituitarismo.
- Estudio triple: RM de silla turca con gadolinio, campimetría y perfil hormonal completo (prolactina, IGF-1, cortisol/ACTH, TSH/T4L, FSH/LH).
- Prolactinoma: cabergolina aunque haya hemianopsia (no cirugía). Macroadenoma no funcionante compresivo, GH o ACTH: cirugía transesfenoidal.
- Apoplejía hipofisaria (cefalea en trueno, pérdida visual, III par): hidrocortisona 100 mg EV inmediata y RM urgente. Seguimiento: derivar a endocrinología y neurocirugía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 80

Una mujer de 55 años consulta por cefalea progresiva, de localización interciliar y occipital, asociada a alteraciones visuales. Al examen físico, tiene hemianopsia heterónima, sin alteraciones motoras ni de la sensibilidad. **¿En qué estructura anatómica se encuentra con mayor probabilidad la lesión?**

A) En las retinas
B) En ambos nervios ópticos
C) En el lóbulo occipital
D) En la radiación óptica
E) En el quiasma óptimo

Respuesta E. Hemianopsia heterónima (bitemporal): lesión del quiasma óptico, típicamente por un tumor hipofisario. El nervio óptico da amaurosis de un ojo; el lóbulo occipital, la radiación y la cintilla dan hemianopsia homónima contralateral.

1.10.1.029 Tumores primarios y metastásicos SNC

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores del SNC: metástasis son los más frecuentes en adultos (pulmón, mama, melanoma, riñón, colon); primarios: glioblastoma, meningioma; en niños, fosa posterior (meduloblastoma, astrocitoma pilocítico).
- Sospechar ante cefalea progresiva matinal con vómitos (hipertensión endocraneana), crisis de inicio tardío o focales, déficit focal progresivo o cambio cognitivo-conductual.
- Estudio: TAC o RM con contraste (lesión con realce en anillo y edema); en cáncer pulmonar la etapificación incluye RM de cerebro.
- Manejo inicial: dexametasona para el edema vasogénico, antiepiléptico solo si hubo crisis, control de la hipertensión endocraneana; no hacer punción lumbar antes de la imagen.
- Diferencial de lesión en anillo: absceso cerebral (fiebre, foco ótico o sinusal) y neurocisticercosis.
- Seguimiento: derivar a neurocirugía y oncología (cirugía, radioterapia; en microcítico, irradiación holocraneal profiláctica).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 61 años, fumador, con adenocarcinoma pulmonar recién diagnosticado, consulta por cefalea matinal progresiva, vómitos y paresia leve de la mano derecha. La resonancia cerebral muestra 3 lesiones redondeadas con realce en anillo en la unión córtico-subcortical, rodeadas de extenso edema vasogénico. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado de los síntomas?**

A) Dexametasona
B) Manitol en infusión continua por 2 semanas
C) Antibióticos por absceso cerebral
D) Anticoagulación
E) Punción lumbar evacuadora

Respuesta A. Lesiones múltiples con realce en anillo en la unión córtico-subcortical, en un paciente con cáncer pulmonar, corresponden a metástasis cerebrales, los tumores intracraneales más frecuentes del adulto. Los síntomas por edema vasogénico se tratan con dexametasona; luego se define radiocirugía, radioterapia o cirugía. La punción lumbar está contraindicada por el efecto de masa.

Situaciones clínicas de urgencia 21 códigos

1.10.2.001 Cefalea aguda en urgencia

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino · Tema 10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero buscar banderas rojas (SNOOP10): síntomas sistémicos, focalidad o compromiso de conciencia, inicio en trueno, >50 años, cambio de patrón, empeora con Valsalva o decúbito, papiledema.

- Cefalea en trueno: TAC sin contraste inmediato; si es normal, punción lumbar a las 6–12 h buscando xantocromía (hemorragia subaracnoidea).
- Fiebre con meningismo: hemocultivos, dexametasona y antibióticos antes de la imagen (meningitis). Cefalea nueva en >50 años: VHS y PCR (arteritis de la temporal).
- Mujer joven con anticonceptivos o puerperio y cefalea progresiva con signos de HTEC: trombosis venosa cerebral (angio-RM venosa; TAC normal no descarta).
- Crisis migrañosa típica sin banderas rojas: no requiere imagen; hidratación, ketorolaco EV y metoclopramida EV (sumatriptán SC alternativa); evitar opioides.
- Seguimiento: derivar según la causa secundaria; las primarias se controlan en APS.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 34 años consulta en urgencia por cefalea holocránea de 10 días, progresiva, que empeora al toser y al acostarse, con vómitos matinales. Usa anticonceptivos orales. Afebril, PA 124/78 mmHg, sin rigidez de nuca ni déficit motor. **¿Cuál de los siguientes hallazgos es una bandera roja que obliga a neuroimagen urgente?**

A) Fotofobia y náuseas
B) Antecedente familiar de migraña
C) Edema de papila bilateral en el fondo de ojo
D) Dolor opresivo bilateral
E) Alivio parcial con paracetamol

Respuesta C. Una cefalea nueva o progresiva con banderas rojas (SNOOP: síntomas sistémicos, signos neurológicos como edema de papila, inicio súbito, inicio después de los 50 años, cambio de patrón o empeoramiento con Valsalva y decúbito) obliga a neuroimagen. El edema de papila indica hipertensión endocraneana. Fotofobia, náuseas y dolor opresivo son propios de cefaleas primarias.

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años con migraña sin aura diagnosticada hace 8 años consulta en urgencia por una crisis igual a las habituales, de 10 horas de evolución, hemicránea pulsátil con fotofobia y vómitos repetidos que le impiden tomar medicamentos orales. Afebril, PA 118/74 mmHg, examen neurológico normal, sin rigidez de nuca. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) TAC de encéfalo urgente antes de tratar
B) Morfina EV
C) Punción lumbar
D) Hidratación EV, ketorolaco EV y metoclopramida EV, sin neuroimagen
E) Sumatriptán oral y alta inmediata

Respuesta D. Crisis migrañosa típica, igual a las previas y sin banderas rojas: no requiere imagen. Con vómitos se usa la vía parenteral: AINE EV (ketorolaco) más antiemético antidopaminérgico (metoclopramida), con hidratación; el sumatriptán subcutáneo es alternativa. Los opioides se evitan por cefalea de rebote y recurrencia; la vía oral fallará con vómitos.

1.10.2.002 Complicaciones neurológicas de abuso de sustancias

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Cocaína y pasta base: toxíndrome simpaticomimético (midriasis, taquicardia, HTA, hipertermia, agitación, psicosis paranoide); complicaciones neurológicas: ACV isquémico o hemorrágico, convulsiones, hemorragia subaracnoidea.
- Manejo: benzodiacepinas EV (diazepam 5–10 mg o lorazepam 2–4 mg) para agitación, HTA y convulsiones; nunca betabloqueadores puros (alfa sin oposición).
- Benzodiacepinas: sopor, ataxia, disartria y nistagmo con signos vitales estables; soporte ventilatorio. Flumazenil contraindicado en usuarios crónicos o coingesta de tricíclicos (status epiléptico).
- Opioides: miosis puntiforme, bradipnea y coma; naloxona EV.
- Alcohol: abstinencia con convulsiones (12–48 h, tratar con benzodiacepinas, no fenitoína), delirium tremens y encefalopatía de Wernicke (tiamina antes de la glucosa).
- Seguimiento: derivar a programa de adicciones tras estabilizar; entrevista motivacional según la etapa de cambio.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 29 años es traído a urgencia 1 hora después de consumir cocaína por cefalea súbita intensa y hemiparesia izquierda. PA 210/120 mmHg. **¿Cuál es el examen más importante a realizar de inmediato?**

A) Electroencefalograma
B) Punción lumbar
C) TAC de cerebro sin contraste
D) Toxicológico en orina como único examen
E) Ecocardiograma

Respuesta C. La cocaína produce vasoconstricción, crisis hipertensivas y vasculitis, causando ACV isquémico, hemorragia intracerebral y subaracnoidea en jóvenes, además de convulsiones. Ante un déficit focal agudo se realiza de inmediato una TAC de cerebro sin contraste para distinguir hemorragia de isquemia. La agitación y la hipertensión se manejan con benzodiacepinas, evitando betabloqueadores.

1.10.2.003 Crisis convulsiva

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.9 Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo · Tema 10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis convulsiva activa: proteger de lesiones, posición lateral, ABC, oxígeno y glicemia capilar; no introducir objetos en la boca.
- La mayoría se autolimita antes de 2 minutos; si dura ≥5 minutos o hay crisis repetidas sin recuperar conciencia es estatus: benzodiacepina inmediata (lorazepam 4 mg EV o midazolam 10 mg IM).
- Diferenciar del síncope convulsivo (pródromos, mioclonías <15 s, recuperación lúcida) y de crisis psicógenas (movimientos asincrónicos, ojos cerrados con fuerza).
- Buscar causa provocada: hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, abstinencia alcohólica, tóxicos, infección del SNC, TEC, ACV; en embarazada con HTA, eclampsia (sulfato de magnesio).
- Estudio de primera crisis: electrolitos, función renal y hepática, ECG, TAC en urgencia y luego RM y EEG.
- Seguimiento: derivar a neurología; no conducir por 6–12 meses.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 166

Mujer de 17 años presenta súbitamente desviación de la cabeza hacia la derecha y cae al suelo. Su madre presenció el hecho y observó que mantuvo la mirada conjugada hacia la derecha, tras lo cual presentó hipertonía de todo el cuerpo, seguida de movimientos rítmicos de las 4 extremidades. Se recupera somnolienta y adolorida, con signos de haberse mordido la lengua, con impresión de la arcada dentaria en la zona lateral de la lengua. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Crisis convulsiva primariamente generalizada
B) Crisis focal secundariamente generalizada
C) Síncope vasovagal
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno facticio

Respuesta B. La desviación versiva inicial de la cabeza y la mirada indica un inicio focal (frontal, contralateral a la desviación), seguido de fases tónica y clónica generalizadas, con mordedura lateral de lengua y estado postictal: crisis focal con evolución a bilateral tónico-clónica. Ese inicio focal descarta que sea primariamente generalizada y obliga a buscar una lesión estructural.

Pregunta de práctica

Mujer de 22 años, sana, de pie en una fila bancaria calurosa y concurrida, refiere mareo intenso, visión borrosa y náuseas; se pone pálida y sudorosa y cae al suelo, inconsciente por unos 20 segundos. Una testigo describe sacudidas breves y aisladas de ambos brazos por unos 5 segundos. A los 2 minutos está despierta, orientada y recuerda los síntomas previos. Sin incontinencia ni mordedura de lengua. Examen físico y neurológico normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar levetiracetam y solicitar EEG ambulatorio
B) Solicitar resonancia magnética de cerebro y EEG antes de decidir
C) Explicar el diagnóstico de síncope vasovagal y educar en maniobras de contrapresión
D) Iniciar ácido valproico por tratarse de una crisis generalizada
E) Hospitalizar para video-EEG

Respuesta C. Síncope vasovagal con mioclonías anóxicas (síncope convulsivo): gatillante claro, pródromos autonómicos, inconsciencia breve, sacudidas de menos de 15 s tras el colapso, sin mordedura lateral ni incontinencia, y recuperación inmediata y lúcida. No es una crisis epiléptica: no requiere EEG ni antiepilépticos; se educa en maniobras de contrapresión y medidas higiénico-dietéticas.

1.10.2.004 Estado confusional agudo (alcohólico, tóxico metabólico)

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.21 Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente · Tema 17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- Delirium (CAM): inicio agudo y fluctuante + inatención (MUNDO al revés), más pensamiento desorganizado o conciencia alterada. El hipoactivo es el más frecuente y grave.
- Buscar siempre la causa (I WATCH DEATH): infección urinaria o neumonía, metabólica, hipoxia, fármacos anticolinérgicos, benzodiacepinas u opioides; globo vesical y fecaloma.
- Abstinencia alcohólica: temblor (6–12 h), alucinosis lúcida (12–24 h), convulsiones (12–48 h) y delirium tremens (48–96 h: confusión, disautonomía, fiebre, zoopsias; mortalidad 5–15%).
- Delirium tremens: diazepam 10–20 mg según CIWA-Ar (lorazepam si cirrosis), hospitalizar (UPC si grave); tiamina 100–300 mg EV antes de cualquier glucosado (Wernicke: oftalmoplejía, ataxia, confusión).
- Delirium común: medidas no farmacológicas (reorientar, lentes, audífonos, sueño, sin sujeción); haloperidol 0,5–1 mg solo si hay riesgo; quetiapina en Parkinson o Lewy; benzodiacepinas contraindicadas fuera de la abstinencia.
- Seguimiento completo: control hasta resolución y de la causa; tras abstinencia, intervención motivacional y naltrexona o disulfiram en programa de alcohol.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años, bebedor de 1 litro de destilado al día, desnutrido, es traído a urgencia por 2 días de confusión e inestabilidad. Desorientado, apático, con nistagmo horizontal, paresia bilateral del recto lateral y ataxia de marcha que le impide caminar sin ayuda. Afebril, PA 128/80 mmHg, glicemia 94 mg/dL, sin signos de abstinencia. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Suero glucosado al 30 % EV en bolo
B) Haloperidol 5 mg IM
C) Tiamina EV en dosis altas, antes o junto con cualquier aporte de glucosa
D) Lorazepam EV como única medida
E) Punción lumbar urgente

Respuesta C. Confusión, oftalmoplejía y ataxia en un alcohólico desnutrido: encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina, una emergencia que basta sospechar. Se administra tiamina EV en dosis altas (por ejemplo, 500 mg cada 8 horas) antes o junto con la glucosa, ya que la glucosa sin tiamina puede precipitar o agravar el cuadro y evolucionar a síndrome de Korsakoff.

1.10.2.005 Distonía aguda por fármacos (ejemplo antieméticos)

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.13 Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Distonía aguda: contracción muscular sostenida y dolorosa minutos a 48 h tras un bloqueador D2 (metoclopramida, haloperidol, antipsicóticos); más en jóvenes y niños.
- Formas: crisis oculógira (mirada fija hacia arriba), tortícolis, protrusión lingual, trismus, opistótonos; conciencia conservada, afebril.
- Tratamiento: biperideno 2,5–5 mg IM o EV lento (alivio en 10–15 min); alternativa difenhidramina EV; luego biperideno oral 2 mg c/8–12 h por 24–48 h.
- Suspender el fármaco causal; la domperidona casi no cruza la barrera hematoencefálica. No requiere TAC ni anticonvulsivantes.
- Diferencial: síndrome neuroléptico maligno (fiebre, rigidez generalizada, compromiso de conciencia, CK alta) y crisis epiléptica.
- No requiere seguimiento: educar sobre el fármaco causal y registrarlo como reacción adversa.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 23 años, sin antecedentes, consulta en urgencia por náuseas y dolor cólico epigástrico tras una comida grasa. Recibe analgesia y metoclopramida 10 mg EV. A los 40 minutos presenta ojos desviados de forma fija hacia arriba, contractura cervical dolorosa con rotación del mentón hacia la izquierda y protrusión de la lengua con dificultad para hablar. Está angustiada. PA 125/75 mmHg, FC 82 lpm, afebril, Glasgow 15, pupilas isocóricas reactivas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Diazepam 10 mg EV y TAC de cerebro
> **B)** Biperideno 2,5 a 5 mg IM o EV lento
> **C)** Haloperidol 5 mg IM
> **D)** Propranolol 40 mg oral
> **E)** Levodopa/carbidopa oral
>
> Respuesta B. Crisis oculógira, tortícolis y distonía lingual 40 minutos después de metoclopramida EV: distonía aguda por fármacos. El tratamiento es un anticolinérgico central (biperideno IM o EV lento), con alivio en 10–15 minutos y mantención oral por 24–48 horas. No es una crisis epiléptica ni requiere TAC; el haloperidol la empeoraría.

1.10.2.006 Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc)

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Encefalopatía tóxico-metabólica: compromiso de conciencia difuso y fluctuante, sin focalidad, con asterixis, mioclonías y a veces convulsiones; pupilas reactivas.
- Hepática: cirrótico con desorientación y asterixis; buscar precipitante (infección, HDA, constipación, sedantes, diuréticos, hipokalemia). Tratar el precipitante + lactulosa (2–3 deposiciones blandas al día) ± rifaximina.
- Urémica: letargia, asterixis, mioclonías, convulsiones; con pericarditis o encefalopatía es indicación de hemodiálisis urgente.
- Otras: hipoglicemia, hiponatremia o hipernatremia, hipercalcemia, hipercapnia, sepsis, hipotiroidismo, fármacos y Wernicke (tiamina EV).
- Manejo inicial: glicemia capilar, electrolitos, gases, amonio, función renal y hepática, tóxicos; TAC si hay focalidad o trauma; proteger la vía aérea si Glasgow ≤8.
- Seguimiento: derivar según la causa (gastroenterología, nefrología, UPC).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 63 años con cirrosis alcohólica, abstinente, es traído por somnolencia y desorientación de 2 días. Al examen tiene asterixis, sin fiebre ni dolor abdominal, y refiere constipación de 5 días. Glicemia y electrolitos normales. La paracentesis no muestra signos de infección. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Flumazenil
B) Restricción proteica absoluta
C) Benzodiacepinas para la agitación
D) Lactulosa oral para lograr 2 a 3 deposiciones blandas al día
E) Furosemida endovenosa

Respuesta D. Un compromiso de conciencia con asterixis en un cirrótico es una encefalopatía hepática, aquí precipitada por constipación. Se buscan y corrigen los precipitantes (infección, hemorragia, diuréticos, alteraciones electrolíticas) y se indica lactulosa para lograr 2 a 3 deposiciones blandas al día, agregando rifaximina si recurre. La restricción proteica ya no se recomienda y las benzodiacepinas la empeoran.

1.10.2.007 Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES · Tema 10.2 Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria · Tema 10.3 Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos · Tema 10.5 Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena

QUÉ HAY QUE SABER

- Déficit focal súbito (Cincinnati: cara, brazo, habla): código ACV; anotar la hora de inicio o última vez visto bien; glicemia capilar; TAC sin contraste informado en ≤30 min para descartar sangre.
- Isquémico ≤4,5 h sin sangre: trombolisis (alteplase 0,9 mg/kg, máx 90 mg, o tenecteplase 0,25 mg/kg) con PA <185/110; oclusión de gran vaso: trombectomía hasta 6 h (6–24 h con mismatch).
- No trombolizado: hipertensión permisiva hasta 220/120, AAS 250 mg, atorvastatina 80 mg, glicemia 70–180, normotermia; trombolizado: AAS a las 24 h tras TAC de control.
- Hemorrágico: PAS 130–140 con labetalol o nicardipino EV; revertir anticoagulación (acenocumarol: CCP + vitamina K; dabigatrán: idarucizumab); cerebeloso ≥3 cm se opera.
- AIT (déficit resuelto sin infarto en la imagen): ABCD² ≥4 o FA, crescendo o estenosis = hospitalizar; estudio en <48 h; AAS + clopidogrel 21 días si no es cardioembólico; FA: anticoagular; estenosis 70–99%: endarterectomía en <2 semanas.
- GES: atención en UTAC; derivar a neurología y rehabilitación. Infarto lacunar: hemiparesia pura sin afasia ni hemianopsia.

PREGUNTAS (12)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 93

Un paciente de 67 años presenta hemiparesia derecha de dos horas de evolución, que inició de manera súbita y se asocia a dificultades para hablar. Al examen físico tiene hemiparesia faciobraquiocrural derecha y afasia. Su TAC de cerebro es normal. **La conducta más adecuada es:**

A) Anticoagular con heparina
B) Administrar antiagregantes plaquetarios
C) Solicitar resonancia magnética nuclear
D) Realizar embolectomía
E) Realizar trombólisis

Respuesta E. Déficit focal súbito de 2 horas con TAC normal: el TAC descarta hemorragia y confirma un infarto isquémico en ventana (< 4,5 h). Lo más urgente es la trombolisis EV.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 121

Paciente con cefalea súbita y hemiplejia del hemicuerpo izquierdo, sin alteraciones sensitivas ni del habla. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Hemorragia intracerebral en cápsula interna
B) AVE isquémico de territorio carotídeo
C) Hematoma subdural agudo
D) AVE isquémico de territorio basilar
E) Infarto lacunar

Respuesta E. Hemiplejia pura, sin compromiso sensitivo ni del lenguaje: síndrome lacunar motor puro (brazo posterior de la cápsula interna). La ausencia de afasia, hemianopsia y negligencia indica que no hay compromiso cortical.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 76

Un paciente de 32 años presenta dolor cervical intenso, mientras realizaba deporte, que se irradia hacia la cara, zona temporal y se asocia a cefalea intensa. Al examen físico se observa ptosis y miosis derechas. **El diagnóstico más probable es:**

A) Parálisis del tercer nervio craneal
B) Aneurisma cerebral anterior, con compromiso del tercer nervio craneal
C) Infarto vertebrobasilar
D) Migraña hemipléjica
E) Disección carotidea

Respuesta E. Adulto joven con dolor cervical y cefalea tras esfuerzo o elongación: disección arterial (TOAST: otra etiología determinada). La ptosis con miosis es un síndrome de Horner por compromiso simpático a nivel de la carótida.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 1

Una paciente de 40 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cefalea holocránea, muy intensa, de 5 días de evolución, que se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios, mayores en la mañana, y que no ha respondido al uso de analgésicos orales. Hoy presentó una convulsión tónico-clónica. En su examen físico tiene sopor superficial paresia de las extremidades derechas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Migraña por anticonceptivos
B) Infarto cerebral extenso
C) Accidente vascular lacunar
D) Epilepsia con parálisis de Todd
E) Trombosis venosa cerebral

Respuesta E. Cefalea progresiva de días con vómitos matinales (signos de hipertensión endocraneana), convulsión y déficit focal en usuaria de anticonceptivos orales: trombosis venosa cerebral, una de las causas de "otra etiología determinada" en TOAST.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 26

Un paciente de 60 años, con hipertensión arterial de larga data mal controlada, consulta por cefalea intensa que ha aumentado en intensidad hasta EVA 9/10, asociada a vómitos y mareos de 2 horas de evolución, por lo que acude al servicio de urgencias. Al examen físico presenta presión arterial 170/105 mmHg y frecuencia cardíaca 62 lpm, sin signos focales en el examen neurológico. Se solicita una TAC de cerebro que se muestra a continuación: **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hematoma subdural
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Infarto de arteria cerebral media con transformación hemorrágica
D) Hematoma talámico derecho
E) Hemorragia intraparenquimatosa secundaria a malformación arteriovenosa

Respuesta D. La TAC original mostraba una hiperdensidad (sangre) intraparenquimatosa en el tálamo. Hipertenso crónico mal controlado con cefalea y vómitos: hemorragia hipertensiva en un núcleo profundo. Contraindica antiagregantes, anticoagulación y trombólisis; la meta es una PAS cercana a 140 mmHg. La MAV se piensa en el joven o no hipertenso.

Pregunta de práctica

Hombre de 67 años, hipertenso. Hace 90 minutos presentó en forma súbita afasia y hemiparesia derecha braquiocrural (NIHSS 13). PA 205/115 mmHg, glicemia 118 mg/dL. El TAC de encéfalo sin contraste, informado a los 25 minutos del ingreso, es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar alteplase 0,9 mg/kg de inmediato
B) Labetalol EV hasta PA < 185/110 mmHg y luego trombolisis
C) No tratar la presión: hipertensión permisiva hasta 220/120 mmHg
D) AAS 250 mg y hospitalizar en UTAC
E) Solicitar resonancia magnética antes de decidir

Respuesta B. Infarto de la ACM izquierda en ventana (< 4,5 h), TAC sin sangre: candidato a trombolisis. La PA debe estar < 185/110 mmHg antes de iniciar el trombolítico: se baja con labetalol o nicardipino EV y luego se tromboliza. La hipertensión permisiva hasta 220/120 es para el paciente no trombolizado.

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años, hipertenso y fumador, no diabético. Hace 2 horas presentó debilidad súbita de mano y pierna derechas con dificultad para articular palabras, que se resolvió por completo en unos 45 minutos. PA 155/95 mmHg, FC 80 lpm regular. Examen neurológico normal. TAC de encéfalo sin contraste sin sangrado ni lesiones isquémicas recientes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Alta con AAS 100 mg y control con neurólogo en 1 mes
B) Trombolisis intravenosa con alteplase
C) Hospitalizar, estudio etiológico y AAS + clopidogrel por 21 días
D) Hospitalizar e iniciar anticoagulación oral
E) Hospitalizar y AAS + clopidogrel de forma indefinida

Respuesta C. AIT carotídeo izquierdo. ABCD² = 5 (edad ≥ 60: 1; PA ≥ 140/90: 1; debilidad unilateral: 2; duración 10–59 min: 1): riesgo moderado, se hospitaliza. Se completa el estudio (Doppler carotídeo, monitoreo cardíaco, resonancia) y se inicia AAS + clopidogrel por exactamente 21 días, más atorvastatina 80 mg.

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años con fibrilación auricular en tratamiento con acenocumarol e HTA mal controlada. Presenta cefalea súbita, vómitos explosivos y hemiplejia izquierda. PA 205/115 mmHg, Glasgow 11, desviación conjugada de la mirada hacia la derecha. TAC sin contraste: hematoma de 32 mL en el putamen derecho con invasión ventricular. INR 3,4. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Plasma fresco congelado y vitamina K oral; control de PA si supera 220 mmHg
B) Complejo protrombínico de 4 factores + vitamina K EV y labetalol EV hasta PAS 130–140 mmHg
C) Evacuación quirúrgica abierta del hematoma putaminal
D) Nitroprusiato EV hasta PAS menor de 120 mmHg y suspender el acenocumarol
E) Idarucizumab 5 g EV y nicardipino EV

Respuesta B. Hemorragia putaminal hipertensiva agravada por acenocumarol (INR 3,4). Dos medidas simultáneas en minutos: CCP 4F (25–50 UI/kg) + vitamina K1 10 mg EV, y labetalol o nicardipino EV a PAS 130–140 mmHg sin bajar de 130. Ingreso a UCI con evaluación neuroquirúrgica. La evacuación abierta del putamen no está indicada de rutina (STICH). El idarucizumab revierte dabigatrán, no acenocumarol.

Pregunta de práctica

Mujer de 29 años, en su 4° día de puerperio, usuaria de anticonceptivos orales combinados hasta el embarazo. Consulta por 4 días de cefalea holocránea progresiva que empeora al acostarse y al toser, con vómitos matinales. En las últimas 12 horas presentó 3 crisis focales del brazo derecho con generalización. Somnolienta, con papiledema bilateral y leve paresia braquial derecha. TAC sin contraste: lesión hipodensa temporoparietal izquierda con focos hiperdensos petequiales, que no respeta un territorio arterial. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Evitar la anticoagulación por la transformación hemorrágica e iniciar levetiracetam
B) Trombolisis intravenosa con alteplase
C) Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas SC, levetiracetam EV e ingreso a UPC
D) Punción lumbar evacuadora y acetazolamida
E) Aspirina 300 mg y control con resonancia en 48 horas

Respuesta C. Trombosis venosa cerebral con infarto venoso hemorrágico en una puérpera usuaria de ACO: cefalea progresiva con signos de HTEC, convulsiones y lesión que no respeta territorios arteriales. La hemorragia se debe a la hipertensión venosa retrógrada: se anticoagula igual, con HBPM en dosis plena. Como hubo crisis, se agrega levetiracetam. Se confirma con Angio-RM venosa o AngioTAC venosa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 66 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 72 años llega a urgencias con hemiparesia derecha y afasia de inicio súbito hace 5 horas. TAC de cerebro sin contraste: normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antiagregación plaquetaria (aspirina 250 mg) e hospitalización
B) Trombolizar con rtPA (ya pasaron >4.5h, fuera de ventana)
C) Trombectomía mecánica (evaluar si hay oclusión de gran vaso)
D) Observación domiciliaria
E) Anticoagulación con heparina inmediata

Respuesta A. ACV isquémico a las 5 horas: fuera de ventana para trombolisis (>4.5h). Si no hay oclusión de gran vaso, el tratamiento es antiagregación (aspirina) + hospitalización para monitoreo y estudios etiológicos. Anticoagulación no está indicada en ACV isquémico agudo de forma rutinaria.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 119 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 refiere que luego de realizar ejercicios de elongación, presenta dolor súbito en el cuello y en la cabeza, con cefalea en trueno (thunderclap). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cefalea cluster o en racimo
B) Accidente isquémico transitorio
C) Disección de la arteria cerebral o carótida
D) Migraña sin aura desencadenada por el ejercicio.
E) Hernia traumática del núcleo pulposo

Respuesta C. Diagnóstico: Disección de la arteria cerebral o carótida (opción C). La disección era la única opción posible. Sigue siendo un cuadro raro.. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere a

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 97 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 65 años, hipertenso y diabético de larga data, consulta por cefalea intensa de inicio súbito, asociado a dificultades para moverse. Al examen físico tiene una hemiparesia derecha, armónica, sin compromiso de conciencia y con conservación del lenguaje y la sensibilidad. No tiene alteraciones visuales. Como antecedente, ha sufrido golpes por caídas a repetición. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral media
B) Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral anterior
C) Hemorragia de la protuberancia anular o puente de Varolio
D) Accidente vascular encefálico hemorrágico
E) Accidente vascular de tipo lacunar

Respuesta A. Diagnóstico: Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral media (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

1.10.2.008 Hemorragia subaracnoídea

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

QUÉ HAY QUE SABER

- Cefalea en trueno: máxima intensidad en <1 minuto, «la peor de mi vida», a menudo con esfuerzo o Valsalva; puede haber pérdida de conciencia inicial y vómitos.
- Signos meníngeos tardan 6–12 h: su ausencia no la descarta. Parálisis del III par con midriasis = aneurisma de comunicante posterior.
- TAC sin contraste inmediato (sensibilidad ~98–100% en <6 h); si es normal, punción lumbar a las 6–12 h: xantocromía y glóbulos rojos iguales en los 3 tubos.
- Confirmada: angioTAC o angiografía para buscar el aneurisma; asegurarlo con coils o clipaje en 24–72 h (el resangrado es lo más letal).
- Mientras: UPC, PAS <160 con labetalol o nicardipino, analgesia y antieméticos; nimodipino 60 mg c/4 h VO por 21 días; euvolemia; hiponatremia con suero fisiológico o hipertónico, nunca restricción hídrica.
- Complicaciones: vasoespasmo (días 4–14), hidrocefalia (drenaje ventricular) y alteraciones cardíacas. No requiere seguimiento del médico general: derivar a neurocirugía.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 136

Un paciente de 50 años, sin antecedentes, presenta cefalea de inicio súbito mientras hacía deporte, asociado a dolor en la zona cervical posterior y dorsal. Al examen físico presenta reflejo fotomotor conservado, signos meníngeos presentes, fuerza y sensibilidad disminuidas en hemicuerpo izquierdo. **El diagnóstico más probable es:**

A) Hemorragia subaracnoídea
B) Hematoma epidural
C) Hematoma subdural
D) Hemorragia cerebral intraparenquimatosa
E) Accidente vascular isquémico

Respuesta A. Cefalea súbita durante el ejercicio, con dolor cervical y signos meníngeos: hemorragia subaracnoidea. Los signos focales no son lo típico, pero pueden aparecer. Sin trauma no se piensa en hematoma epidural ni subdural; la hemorragia intraparenquimatosa daría cefalea con déficit focal, y lo que domina aquí es lo meníngeo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 139

Un paciente de 54 años, alcohólico e hipertenso, hace una semana suspende todos los antihipertensivos. Es traído a la urgencia por cefalea muy intensa, de inicio agudo, asociado a desorientación y compromiso de conciencia. Al examen físico está soporoso, no habla ni sigue indicaciones, aunque mantiene movilidad espontánea de las 4 extremidades. Sus reflejos osteotendíneos y tono muscular son normales y tiene signo de Babinski bilateral. **El diagnóstico más probable es:**

A) Hemorragia subaracnoidea
B) Meningitis bacteriana
C) Edema cerebral
D) Intoxicación etílica
E) Accidente vascular isquémico extenso

Respuesta A. Cefalea muy intensa de inicio agudo con compromiso de conciencia y sin déficit motor focal, en un hipertenso sin tratamiento: hemorragia subaracnoidea (el alza brusca de la PIC explica el compromiso de conciencia). No hay fiebre para meningitis, y un infarto extenso daría un déficit focal evidente.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 178

Una paciente de 42 años, hipertensa, presenta cefalea intensa, que inició súbitamente hace 6 horas, mientras realizaba ejercicio y se ha acompañado de vómitos alimentarios. Al examen físico está vigil y orientada, adolorida, con FC: 70x', PA: 140/90 mmHg, en el examen neurológico tiene signos meníngeos presentes, sin alteraciones motoras ni sensitivas. Se solicita TAC de cerebro sin contraste, que muestra hiperdensidad del espacio intercomisural frontal y del espacio subaracnoideo basal. **¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?**

A) Resonancia magnética nuclear de cerebro
B) Punción lumbar
C) TAC de cerebro con contraste
D) Angiografía cerebral
E) Ecocardiograma

Respuesta D. El TAC ya confirmó la hemorragia subaracnoidea (sangre en el espacio interhemisférico y en las cisternas basales). El paso siguiente es el estudio vascular para encontrar el aneurisma y planificar su exclusión: angiografía cerebral (o AngioTAC). La punción lumbar solo se indica si el TAC es normal.

1.10.2.009 Hipertensión endocraneana

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC · Tema 10.3 Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante cefalea progresiva matinal con vómitos, edema de papila bilateral, VI par, compromiso de conciencia progresivo o tras TEC grave.
- Herniación inminente: midriasis unilateral arreactiva, hemiparesia y tríada de Cushing (HTA, bradicardia, respiración irregular); la HTA es compensatoria y no se baja.
- Medidas inmediatas: cabecera a 30° con cuello alineado, vía aérea (intubar si Glasgow ≤8), normoxemia y normocapnia (hiperventilación solo breve como puente), normotermia, evitar hipotensión y sueros hipotónicos.

- Osmoterapia: manitol o suero hipertónico (este último si hay hipotensión); dexametasona solo en edema vasogénico por tumor o absceso.
- TAC sin contraste urgente; punción lumbar contraindicada antes de la imagen.
- Seguimiento: derivar de urgencia a neurocirugía (evacuación de hematoma, drenaje ventricular, monitoreo de PIC).

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 45 años con TEC grave y contusiones cerebrales, intubado. Evoluciona con presión arterial 190/100, frecuencia cardíaca 48, respiración irregular y midriasis derecha arreactiva. Se coordina con neurocirugía. **¿Cuál es la medida inicial más adecuada mientras tanto?**
>
> **A)** Administrar labetalol para normalizar la presión arterial
> **B)** Administrar atropina por la bradicardia
> **C)** Hiperventilar en forma prolongada hasta PaCO2 de 25
> **D)** Realizar punción lumbar para medir la presión
> **E)** Elevar la cabecera a 30 grados, asegurar oxigenación y normoventilación, y administrar manitol o suero hipertónico
>
> Respuesta E. Hipertensión, bradicardia y respiración irregular son la tríada de Cushing, signo de hipertensión endocraneana con herniación inminente. Se trata con cabecera a 30 grados, oxigenación y normoventilación, y osmoterapia con manitol o suero hipertónico. La hipertensión es compensatoria y no se debe bajar; la punción lumbar está contraindicada.

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 47 años con 3 semanas de cefalea progresiva de predominio matinal y vómitos. Hoy su familia lo encuentra somnoliento. Glasgow 10, pupila derecha de 5 mm hiporreactiva, hemiparesia izquierda. PA 186/94 mmHg, FC 52 lpm, respiración irregular. TAC de encéfalo: masa frontotemporal derecha con extenso edema vasogénico y desviación de la línea media de 9 mm. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**
>
> **A)** Punción lumbar para medir la presión de apertura
> **B)** Cabecera a 30°, asegurar la vía aérea, manitol EV, dexametasona EV y evaluación neuroquirúrgica urgente
> **C)** Hiperventilación sostenida con meta de PaCO2 de 25 mmHg durante 48 horas
> **D)** Suero glucosado al 5 % para hidratación
> **E)** Nitroprusiato EV para llevar la PA sistólica bajo 100 mmHg
>
> Respuesta B. Hipertensión endocraneana con signos de herniación (sopor, midriasis ipsilateral, tríada de Cushing) por un tumor con edema: cabecera a 30°, vía aérea segura, osmoterapia (manitol o suero hipertónico), dexametasona por el edema vasogénico y neurocirugía urgente. La punción lumbar puede precipitar herniación; los sueros hipotónicos y la hipotensión empeoran el daño.

1.10.2.010 Movimientos anormales inducidos por fármacos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.12 Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

QUÉ HAY QUE SABER

- Distonía aguda (minutos a 48 h tras metoclopramida o haloperidol): crisis oculógira, tortícolis, trismus; biperideno 2,5–5 mg IM o EV.
- Acatisia (días): inquietud motora subjetiva e incapacidad de quedarse quieto; reducir dosis, propranolol o benzodiacepina.
- Parkinsonismo farmacológico (semanas): bilateral y simétrico, subagudo, sin pródromos; fármacos: metoclopramida, levosulpirida, antipsicóticos, flunarizina y cinarizina. Suspender gradualmente; no dar levodopa; remite en semanas a meses.
- Disquinesia tardía (meses a años): movimientos orofaciales de masticación y lengua; suspender o cambiar a antipsicótico atípico (clozapina, quetiapina).
- Síndrome neuroléptico maligno: fiebre, rigidez generalizada, compromiso de conciencia, disautonomía y CK alta: suspender el fármaco y UCI. Síndrome serotoninérgico: clonus e hiperreflexia con ISRS.
- No requiere seguimiento especial: revisar siempre la receta y evitar el fármaco causal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 74 años, hipertensa, con síndrome vertiginoso recurrente. Hace 4 meses se mueve con extrema lentitud y le tiemblan las manos al tomar la taza. Usa losartán, hidroclorotiazida, flunarizina 10 mg/noche (hace 9 meses) y metoclopramida 10 mg c/8 h (hace 6 meses). Examen: hipomimia, bradicinesia y rigidez en rueda dentada bilaterales y simétricas, temblor postural fino de ambas manos, sin temblor de reposo. Sin parálisis de la mirada vertical ni caídas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar levodopa/carbidopa
B) Suspender gradualmente flunarizina y metoclopramida y controlar
C) Iniciar pramipexol
D) Solicitar RM cerebral y derivar por sospecha de parálisis supranuclear progresiva
E) Iniciar propranolol por temblor esencial

Respuesta B. Parkinsonismo subagudo, bilateral y simétrico, con temblor postural, en una paciente que usa dos bloqueadores dopaminérgicos: parkinsonismo inducido por fármacos. Se suspenden gradualmente ambos fármacos; la recuperación puede tardar semanas a meses. No hay banderas rojas de PSP.

1.10.2.011 Paraplejia aguda

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 8.22 Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

QUÉ HAY QUE SABER

- Paraplejia aguda: debilidad de ambas piernas de instalación aguda con nivel sensitivo en el tronco y trastorno esfinteriano (retención urinaria) = lesión medular hasta demostrar lo contrario.
- Compresión medular neoplásica (metástasis vertebral de mama, pulmón, próstata, mieloma): dolor raquídeo progresivo y nocturno que precede a la paraparesia; la retención urinaria es tardía.
- Ante la sola sospecha: dexametasona 16–24 mg EV y RM de columna completa urgente; luego radioterapia o cirugía descompresiva.
- Otras causas: trauma raquimedular, hematoma o absceso epidural (fiebre, punción o anticoagulación), mielitis transversa (esclerosis múltiple, posinfecciosa), infarto medular (disección aórtica), Guillain-Barré (arreflexia sin nivel sensitivo).
- Medidas: sonda vesical, prevención de úlceras por presión y de TVP; no movilizar sin inmovilización si hay trauma.
- No requiere seguimiento del médico general: derivar de urgencia a neurocirugía u oncología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 72 años con cáncer de próstata metastásico presenta dolor dorsal de 3 semanas que empeora en decúbito y, desde hace 24 horas, debilidad de ambas piernas, con nivel sensitivo en T10 y retención urinaria. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar opioides y control en 1 semana
B) Radiografía de columna y control ambulatorio
C) Punción lumbar
D) Kinesioterapia motora
E) Dexametasona endovenosa y resonancia magnética urgente de toda la columna

Respuesta E. Una paraplejia aguda con nivel sensitivo y alteración esfinteriana en un paciente oncológico es una compresión medular neoplásica, emergencia oncológica. Se inicia dexametasona de inmediato y se realiza una resonancia urgente de toda la columna para definir radioterapia o cirugía descompresiva. El pronóstico funcional depende del estado neurológico al iniciar el tratamiento.

1.10.2.012 Síndrome cuadraplégico agudo

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Tetraparesia (cuadriplejia) aguda: localizar entre médula cervical (nivel sensitivo, esfínteres, reflejos vivos tras la fase de shock), tronco, nervio periférico (Guillain-Barré) o placa/músculo.

- Guillain-Barré: debilidad flácida simétrica ascendente con arreflexia, 1–4 semanas tras infección (Campylobacter, virus); puede comprometer pares craneales (diplejía facial) y dar disautonomía.
- Lo que mata es la falla respiratoria silenciosa: monitorizar capacidad vital cada 4–6 h (regla 20/30/40) y conteo en una espiración; la saturación cae tarde.
- UCI e intubación electiva si CVF <15–20 mL/kg, compromiso bulbar o disautonomía grave; nunca succinilcolina (hiperkalemia): usar rocuronio.
- Otras causas: compresión medular cervical (RM urgente), hiperkalemia (dializado que omite sesión: ECG), parálisis periódica hipokalémica (reflejos presentes), miastenia, botulismo.
- No requiere seguimiento del médico general: hospitalizar en UPC o intermedio y derivar a neurología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 34 años con diarrea hace 2 semanas presenta debilidad progresiva de 4 días, que comenzó en las piernas y ahora compromete los brazos, con arreflexia generalizada y parestesias distales. Hoy refiere dificultad para respirar al acostarse. **¿Cuál es el parámetro más importante a monitorizar en forma seriada?**

A) Capacidad vital forzada
B) Creatinquinasa (CK)
C) Saturación de oxígeno como único parámetro
D) Velocidad de sedimentación
E) Glicemia

Respuesta A. Una tetraparesia aguda arrefléctica tras una diarrea sugiere síndrome de Guillain-Barré. El riesgo vital es la insuficiencia respiratoria neuromuscular, por lo que se monitoriza en forma seriada la capacidad vital forzada: valores menores de 20 mL/kg indican necesidad de UCI e intubación. La saturación cae tardíamente. El tratamiento es inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis.

1.10.2.013 Síndrome cuadriparético fláccido (poliradiculoneurítis aguda, Guillain-Barré)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Guillain-Barré: tetraparesia flácida, simétrica y ascendente con arreflexia, nadir a las 2–4 semanas; dolor radicular frecuente; pares craneales en >50% (diplejía facial) y disautonomía.
- Antecedente de infección 1–4 semanas antes (Campylobacter, CMV, EBV, influenza). Variante Miller Fisher: ataxia, arreflexia y oftalmoplejía (anti-GQ1b).
- LCR: disociación albúmino-citológica (proteínas altas, <10 células), puede ser normal la primera semana; >50 células obliga a buscar otra causa. EMG con onda F prolongada.
- Monitorizar capacidad vital (regla 20/30/40): UCI e intubación electiva con rocuronio si cae; la saturación normal no tranquiliza.
- Inmunoterapia si la marcha está alterada o progresa: inmunoglobulina EV 0,4 g/kg/día por 5 días o plasmaféresis; no combinarlas; corticoides contraindicados.
- Soporte: enoxaparina profiláctica, kinesiterapia precoz, gabapentina o pregabalina para el dolor. No requiere seguimiento del médico general: derivar a neurología.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 23

Un paciente de 29 años consulta por un cuadro de 7 días, progresivo, de disminución de la fuerza muscular, tanto en las extremidades superiores, como en las inferiores, siendo mayor en las inferiores. Tiene el antecedente de haber sufrido una influenza hace 14 días. Al examen físico tiene arreflexia aquiliana bilateral, asociada a hiporreflexia rotuliana mayor a derecha, con paresia M4 en las extremidades superiores y M3 en las inferiores. **El diagnóstico más probable es:**

A) Radiculopatía S1 derecho
B) Polineuropatía desmielinizante aguda
C) Meningitis viral
D) Mielopatía por influenza
E) Miositis viral

Respuesta B. Infección 2 semanas antes, debilidad progresiva de las cuatro extremidades de predominio en las piernas e hipo o arreflexia: síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía desmielinizante aguda.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 85

Un paciente de 38 años consulta por paresia facial bilateral, de una semana de evolución, mayor a izquierda. Además, presenta paresia del sexto bervio craneal izquierdo. Al examen físico tiene disminución generalizada de las fuerzas de las extremidades, con arreflexia e hipotonía. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Polineuropatía
B) Síndrome de Guillain Barré
C) Miastenia gravis
D) Esclerosis múltiple
E) Infarto de troncoencéfalo

Respuesta B. Diplejía facial (el par craneal más comprometido en el Guillain-Barré), compromiso de otro par craneal y debilidad generalizada con arreflexia e hipotonía: síndrome de Guillain-Barré.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 165

Un paciente de 24 años, sin antecedentes, es traído porque desde que despertó en la mañana no puede movilizar sus cuatro extremidades, sin otros síntomas. Al examen físico se corrobora fuerza totalmente disminuida en todo su cuerpo, sensibilidad normal, reflejos osteotendíneos presentes y simétricos. **El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Miastenia Gravis
C) Botulismo
D) Lesión medular cervical
E) Parálisis periódica hipokalémica

Respuesta E. Debilidad de las cuatro extremidades que aparece al despertar, con reflejos presentes: no es Guillain-Barré, porque este tiene reflejos abolidos. Por descarte, parálisis periódica hipokalémica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 86

Una mujer de 32 años consulta por debilidad progresiva en ambas piernas, que inició hace 5 días y ha avanzado a las extremidades superiores en las últimas 48 horas. Refiere sensación de hormigueo en manos y pies, pero sin alteración sensorial significativa. No presenta fiebre ni dolor. Hace dos semanas tuvo un cuadro de infección respiratoria con tos y congestión nasal. Al examen físico, destaca debilidad simétrica en las extremidades, arreflexia global y marcha inestable. No hay signos de afectación de los pares craneales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar resonancia magnética de columna
B) Iniciar tratamiento con inmunoglobulina intravenosa
C) Solicitar resonancia magnética de cerebro
D) Administrar corticosteroides endovenosos
E) Iniciar aciclovir endovenoso

Respuesta B. Guillain-Barré típico (infección previa, debilidad ascendente simétrica, arreflexia) con marcha alterada: indicación de inmunoterapia precoz con inmunoglobulina EV. Los corticoides están contraindicados.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 170

Paciente de 45 años presenta paresia facial bilateral de instalación progresiva, en 2 semanas, a lo que luego se agrega parálisis del sexto par craneal. Al examen físico, el tono muscular está disminuido de forma simétrica en las cuatro extremidades, con reflejos osteotendíneos abolidos. **El diagnóstico más probable es:**

A) Accidente vascular tronco encefálico
B) Miastenia gravis
C) Sd. de Guillain Barre
D) Botulismo
E) Hemorragia intracraneana

Respuesta C. Parálisis facial bilateral progresiva, con otro par craneal y tetraparesia flácida arrefléctica: síndrome de Guillain-Barré. La parálisis facial bilateral nunca se asume como Bell.

Pregunta de práctica

Hombre de 34 años con diarrea autolimitada hace 2 semanas. Hace 4 días inicia hormigueo en los pies y debilidad que sube a los brazos; ahora le cuesta tragar. PA 155/95 lábil, FC 102, SatO2 97 %. Tetraparesia flácida simétrica y arreflexia universal. Solo logra contar hasta 12 en una espiración. LCR: proteínas 145 mg/dL, 2 células/µL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Metilprednisolona 1 g EV por 5 días y control en sala
B) Ingreso a UCI, intubación electiva con rocuronio e inmunoglobulina EV
C) Intubación con succinilcolina y plasmaféresis más inmunoglobulina
D) Hospitalizar en sala y repetir la punción lumbar en 7 días
E) Oxígeno por naricera y observar, ya que la saturación es normal

Respuesta B. Guillain-Barré (debilidad ascendente, arreflexia, disociación albúmino-citológica) con compromiso bulbar y conteo menor de 20: falla respiratoria inminente. UCI, intubación electiva sin succinilcolina (rocuronio) e inmunoglobulina EV o plasmaféresis, sin combinarlas. Los corticoides están contraindicados y la saturación normal no tranquiliza.

1.10.2.014 Síndrome encefalítico (Herpes Simplex)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

QUÉ HAY QUE SABER

- Encefalitis herpética (VHS-1, la encefalitis esporádica más frecuente): fiebre + alteración de la función cerebral (conducta bizarra, confusión, alteración de memoria, afasia), crisis focales y alucinaciones olfatorias o gustativas.
- Signos meníngeos ausentes o leves: no esperar rigidez de nuca.
- Ante la sospecha: aciclovir 10 mg/kg c/8 h EV de inmediato por 14–21 días, sin esperar la PCR (baja la mortalidad de >70% a <20%).
- RM: hiperintensidad temporal asimétrica en T2/FLAIR (la TAC puede ser normal las primeras 48–72 h). LCR: pleocitosis linfocítica, glucosa normal, eritrocitos o xantocromía; PCR para VHS-1 confirma (>95%).
- Si hay focalidad, compromiso de conciencia profundo o papiledema, TAC antes de la punción, sin postergar el aciclovir. Diferencial: absceso cerebral (lesión en anillo; no puncionar).
- No requiere seguimiento del médico general: hospitalizar y derivar a neurología/infectología.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 126

Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por cefalea de 3 días de evolución, a lo que se le ha agregado desorientación y confusión. Además, ha presentado algunas convulsiones clónicas. Se realiza punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 células por mm3, con 90% mononucleares, con 15 glóbulos rojos por mm3, glucosa: 80 mg/dl, proteínas: 40 mg/dl; glicemia: 100 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Toxoplasmosis cerebral
B) Meningoencefalitis herpética
C) Tumor cerebral
D) Meningitis viral
E) Meningitis bacteriana aguda

Respuesta B. Alteración de conciencia y convulsiones con LCR de tipo viral pero hemorrágico (glóbulos rojos): encefalitis herpética.

Pregunta de práctica

Hombre de 42 años, sin antecedentes, con 3 días de fiebre leve, cefalea y conducta cada vez más inapropiada y desinhibida. La esposa relata que no comprende lo que se le dice y dice palabras incoherentes. En la evaluación presenta una crisis tónico-clónica focal en brazo y hemicara derechos. T° 38,4 °C, sin rigidez de nuca franca, afasia sensitiva evidente. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Iniciar aciclovir EV 10 mg/kg cada 8 horas
B) Esperar la PCR para VHS en LCR antes de iniciar antivirales
C) Iniciar ceftriaxona + metronidazol EV
D) Solicitar RMN cerebral y decidir el tratamiento según su resultado
E) Iniciar ceftriaxona + vancomicina EV como único tratamiento

Respuesta A. Fiebre, cambio conductual agudo, afasia sensitiva y crisis focales de origen temporal: encefalitis por VHS-1. Se hospitaliza en UTI y se inicia aciclovir EV de inmediato, sin esperar la PCR ni la RMN, porque la letalidad sin tratamiento supera el 70 %.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 42 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con cefalea importante que convulsiona y tiene compromiso de conciencia? (soporoso?), con LCR MN y GR:

A) Encefalitis por VHS
B) MAB
C) Meningitis viral
D) Accidente cerebrovascular
E) Epilepsia

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Encefalitis por VHS). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (MAB, Meningitis viral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

1.10.2.015 Síndromes convulsivos sintomáticos (traumático, por tumores del sistema nervioso central, metabólico, urémico, etc)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis convulsiva secundaria a una causa aguda: TEC, tumor del SNC, ACV, infección (meningitis, encefalitis, absceso, neurocisticercosis), metabólica (hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, uremia) o tóxica (abstinencia alcohólica, cocaína).
- Manejo agudo igual que toda crisis: ABC, glicemia capilar; si dura ≥5 min, lorazepam 4 mg EV o midazolam 10 mg IM y luego levetiracetam o fenitoína EV.
- Estudio: electrolitos, calcio, magnesio, función renal y hepática, tóxicos, ECG y TAC sin contraste; punción lumbar si hay fiebre (tras la imagen si hay focalidad).
- Corregir la causa: glucosa (con tiamina previa en alcohólicos), sodio a velocidad segura, benzodiacepinas en abstinencia, dexametasona en tumor con edema.
- Las crisis metabólicas o tóxicas no requieren antiepiléptico crónico; las estructurales (tumor, secuela de TEC o ACV) sí pueden requerirlo por riesgo de recurrencia.
- Seguimiento: derivar a neurología o neurocirugía según la lesión.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 144

Un adolescente de 14 años presenta cefalea de una semana de evolución. Es traído al servicio de urgencia, tras presentar una convulsión tónico-clónica de 10 minutos de duración, luego de lo que quedó con confusión postictal. Su examen físico no tiene signos focales. Se solicita una tomografía axial computada de cerebro, que muestra una lesión quística de 3 cm en la zona frontotemporal y se realiza una punción lumbar, que muestra proteínas 60 mg/dl, con 70 células por mm3, con 70% de mononucleares y presencia de abundantes eosinófilos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Quiste aracnoidal
B) Astrocitoma pilocítico
C) Encefalitis herpética
D) Meningitis tuberculosa
E) Neurocisticercosis

Respuesta E. Primera crisis con una lesión quística en la TAC y eosinófilos en el LCR: neurocisticercosis (Taenia solium). Muestra por qué toda primera crisis lleva neuroimagen: buscar una causa estructural.

1.10.2.016 Síndromes meníngeos con meningitis purulenta o bacteriana

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Meningitis bacteriana: fiebre, cefalea y rigidez de nuca (la tríada completa en <50%; sin ninguna casi se descarta); Kernig y Brudzinski, fotofobia, vómitos, compromiso de conciencia; púrpura sugiere meningococo.
- TAC antes de la punción si hay focalidad, convulsión reciente, Glasgow <10, papiledema o inmunodepresión; pero hemocultivos, dexametasona y antibióticos van antes de la imagen, nunca al revés.
- Dexametasona 10 mg c/6 h EV por 4 días, 15–20 min antes o junto al antibiótico (reduce secuelas auditivas y mortalidad).
- Empírico 3 meses a 50 años: ceftriaxona 2 g c/12 h + vancomicina 15–20 mg/kg c/12 h; agregar ampicilina 2 g c/4 h en >50 años, embarazadas o inmunodeprimidos (Listeria).
- LCR bacteriano: glucosa baja (razón LCR/suero <0,4), PMN >80%, proteínas >100; viral: glucosa normal y mononucleares.
- Notificación obligatoria y quimioprofilaxis de contactos en meningococo (ciprofloxacino o rifampicina). Seguimiento: derivar (audiometría por secuelas).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años, diabético, presenta fiebre de 39 °C, cefalea intensa, rigidez de nuca y somnolencia de 12 horas, sin déficit focal. Punción lumbar: líquido turbio, 2.800 leucocitos/mm3 con 90% polimorfonucleares, proteínas 210 mg/dL y glucosa 15 mg/dL (glicemia 160 mg/dL). **¿Cuál es el tratamiento empírico más adecuado?**

A) Ceftriaxona sola
B) Penicilina sódica sola
C) Aciclovir endovenoso
D) Ceftriaxona más ampicilina, junto con dexametasona
E) Ciprofloxacino oral

Respuesta D. Un LCR con pleocitosis neutrofílica, proteínas altas y glucosa muy baja confirma una meningitis bacteriana. En mayores de 50 años, embarazadas o inmunosuprimidos se agrega ampicilina a la ceftriaxona para cubrir Listeria, junto con dexametasona antes o con la primera dosis; vancomicina se suma según la resistencia local del neumococo. El aciclovir corresponde a encefalitis herpética.

1.10.2.017 Status convulsivo

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.9 Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Estatus epiléptico convulsivo: crisis ≥5 minutos o crisis repetidas sin recuperar conciencia (t1 = 5 min: tratar; t2 = 30 min: daño neuronal irreversible).
- Fase 1 (0–10 min): ABC, oxígeno, glicemia; lorazepam 4 mg EV (0,1 mg/kg), o midazolam 10 mg IM si no hay vía (intranasal o bucal en niños); repetir una vez; diazepam 10 mg EV como alternativa. Nunca fenitoína de

entrada.

- Fase 2 (10–30 min): levetiracetam 60 mg/kg EV (máx 4.500 mg), fenitoína 20 mg/kg en suero fisiológico a ≤50 mg/min con monitor (nunca en glucosado) o valproato 40 mg/kg.
- Fase 3 (refractario): intubación, UCI, propofol o midazolam en infusión con EEG continuo.
- Complicaciones: rabdomiólisis e IRA (CK, creatinina, hidratación vigorosa), acidosis láctica, hipertermia; coma sin clonías tras el estatus = EEG por estatus no convulsivo. Embarazada con HTA: sulfato de magnesio.
- Buscar la causa (abandono de antiepilépticos, metabólica, infección, TEC). Seguimiento: derivar a neurología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 10.9

Usted evalúa a un recién nacido, diagnosticado de asfixia, con una encefalopatía hipóxica, cae en estatus epiléptico. ¿Qué fármaco debe administrar?

A) Lidocaína
B) Barbitúricos
C) Sulfato de magnesio
D) Fenitoína
E) Lamotrigina

Respuesta B. El estatus epiléptico en un recién nacido, especialmente en el contexto de una encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) secundaria a asfixia, es una emergencia neurológica que requiere tratamiento inmediato para prevenir un mayor daño cerebral. El manejo de las convulsiones neonatales sigue un algoritmo escalonado. El fármaco de primera línea o, en su defecto, el segundo tras el fracaso de las benzodiacepinas (que no están en las opciones), es el **fenobarbital**, un tipo de **barbitúrico**. El fenobarbital es el anticonvulsivo más estudiado y utilizado en el período neonatal. Actúa potenciando la acción del neurotransmisor inhibidor GABA, lo que ayuda a suprimir la actividad eléctrica cerebral anómala y detener las convulsiones. Dada la gravedad del cuadro (estatus epiléptico) y las opciones disponibles, los barbitúricos son la elección correcta y estándar en la práctica clínica neonatal.

1.10.2.018 Status migrañoso

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Status migrañoso: crisis de migraña debilitante de más de 72 horas continuas; descartar banderas rojas antes de atribuirlo a migraña.
- Si la crisis es igual a las habituales y el examen neurológico es normal, no requiere neuroimagen.
- Tratamiento en urgencia: hidratación EV, metoclopramida EV (antiemético antidopaminérgico) y ketorolaco EV; agregar dexametasona para reducir la recurrencia.
- Evitar opioides (cefalea por abuso de medicamentos y recurrencia); no combinar ergotamina con triptán; sumatriptán SC solo si no lo usó en exceso.
- Buscar abuso de analgésicos (AINE ≥15 días/mes, triptán ≥10 días/mes) como factor perpetuante.
- No requiere seguimiento especial tras resolver; indicar profilaxis si cumple criterios (≥3 crisis/mes) y control en APS.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 44 años con epilepsia secundaria a un TEC antiguo, que abandonó sus antiepilépticos hace 5 días. Llega en ambulancia con una crisis tónico-clónica generalizada continua de 25 minutos. Inconsciente, clonías bilaterales, trismus, sialorrea y cianosis peribucal. FC 138 lpm, PA 165/100 mmHg, SatO2 86 % ambiental, T° 38,6 °C. HGT 112 mg/dL. Tiene vía venosa permeable. **Tras asegurar la vía aérea y administrar oxígeno, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Fenitoína 20 mg/kg EV diluida en suero glucosado al 5 %
B) Lorazepam 4 mg EV en bolo lento
C) Observar 5 minutos más, dado que la crisis podría ceder sola
D) Suero glucosado al 30 % EV
E) TAC de cerebro urgente antes de administrar fármacos

Respuesta B. Estatus epiléptico convulsivo de 25 minutos: superó con creces t1 (5 min) y se acerca a t2 (30 min). Tras el ABC, el primer fármaco es una benzodiacepina: lorazepam 4 mg EV (midazolam 10 mg IM si no hubiera vía). Si no cede, fase 2 con levetiracetam 60 mg/kg o fenitoína 20 mg/kg en suero fisiológico a ≤ 50 mg/min con monitor. El HGT es normal, así que la glucosa no está indicada.

Pregunta de práctica

Mujer de 32 años con migraña sin aura conocida presenta una crisis de cefalea pulsátil, con náuseas y fotofobia, de 4 días de duración continua, que no ha cedido con naproxeno ni sumatriptán. Examen neurológico normal, sin fiebre ni signos meníngeos. **¿Cuál es el manejo más adecuado en el servicio de urgencia?**

A) Morfina endovenosa
B) Hidratación, metoclopramida y ketorolaco endovenosos, considerando dexametasona
C) Ergotamina más un segundo triptán
D) Propranolol oral y alta
E) Punción lumbar inmediata

Respuesta B. Una crisis de migraña de más de 72 horas es un status migrañoso. En urgencia se trata con hidratación, un antiemético antidopaminérgico como metoclopramida, un AINE endovenoso como ketorolaco y dexametasona para reducir recurrencias. Los opioides favorecen la cefalea por abuso de medicamentos, ergotamina y triptán no deben combinarse, y el propranolol es profilaxis, no tratamiento agudo.

1.10.2.019 Traumatismo encéfalo craneano leve

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- TEC leve: Glasgow 13–15 (80% de las consultas). El objetivo es detectar a quién pedir TAC y evitar el daño secundario.
- TAC de cerebro sin contraste de urgencia si hay: Glasgow <15 a las 2 h, signos de fractura de base de cráneo (ojos de mapache, Battle, otorraquia o rinorraquia), ≥65 años, anticoagulación, vómitos repetidos, amnesia, pérdida de conciencia, mecanismo de alta energía, focalidad o convulsión.
- Sin factores de riesgo: no requiere imágenes; observación de 4–6 horas y alta con un adulto responsable. La radiografía de cráneo no tiene rol.
- Indicaciones de alarma al alta: cefalea progresiva, vómitos, somnolencia, confusión, convulsión, focalidad o salida de líquido por nariz u oído; analgesia con paracetamol.
- Hematoma epidural: golpe temporal, intervalo lúcido y deterioro brusco con midriasis (craneotomía urgente). Subdural: adulto mayor o anticoagulado con deterioro en días.
- Seguimiento completo: control clínico; síntomas posconmocionales (cefalea, mareo, déficit de concentración) se manejan con reposo relativo y retorno gradual a la actividad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 28 años, sano, se golpea la cabeza al caer de una escalera de 1,5 metros. Sus acompañantes refieren pérdida de conciencia de 1 minuto. En urgencia, 1 hora después, está vigil, con Glasgow 15, sin focalidad neurológica, pero ha vomitado 3 veces y no recuerda el momento de la caída. No usa fármacos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) TAC de cerebro sin contraste
B) Radiografía de cráneo y, si es normal, alta
C) Alta con indicaciones de alarma, porque el Glasgow es 15
D) Resonancia magnética de cerebro electiva
E) Punción lumbar para descartar hemorragia subaracnoidea

Respuesta A. Es un TEC leve, pero con factores de riesgo de lesión intracraneana: pérdida de conciencia, vómitos repetidos y amnesia del evento. Requiere TAC de cerebro sin contraste, que muestra la sangre aguda como hiperdensa. El alta sin imagen corresponde solo al TEC leve sin factores de riesgo; la radiografía de cráneo no descarta lesión intracraneana y la resonancia no es el examen de urgencia.

1.10.2.020 Traumatismo encefalocraneano grave

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- TEC grave: Glasgow ≤8; requiere intubación con restricción de movimiento cervical (asumir lesión cervical) y manejo ATLS (ABCDE).

- Evitar el daño secundario: nunca hipotensión ni hipoxia (un episodio duplica la mortalidad), normocapnia (no hiperventilar salvo herniación como puente), normotermia, glicemia normal, cabecera a 30° con cuello alineado.
- TAC de cerebro sin contraste inmediato (y de columna cervical): epidural (lente biconvexa, intervalo lúcido) requiere craneotomía urgente; subdural agudo en semiluna.
- Herniación (midriasis unilateral arreactiva, tríada de Cushing): suero hipertónico o manitol (con hipotensión, preferir suero hipertónico) y neurocirugía urgente.
- Fractura de base de cráneo (ojos de mapache, Battle, rinorraquia u otorraquia): sonda orogástrica, nunca nasal; no taponar el oído.
- No requiere seguimiento del médico general: traslado a UPC y neurocirugía.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años se golpea la cabeza contra un mueble. No perdió el conocimiento, no ha vomitado, no tiene cefalea intensa ni amnesia. No usa anticoagulantes. Glasgow 15, examen neurológico normal, sin signos de fractura de base de cráneo. Vive acompañada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
B) Alta con indicaciones de signos de alarma y vigilancia por un adulto responsable
C) Solicitar radiografía de cráneo
D) Hospitalizar en observación por 24 horas
E) Solicitar resonancia magnética de cerebro

Respuesta B. TEC leve de bajo riesgo: Glasgow 15, sin pérdida de conciencia, vómitos, amnesia, anticoagulación, edad avanzada ni focalidad. No requiere imágenes: se da de alta con signos de alarma, como cefalea progresiva, vómitos, somnolencia o focalidad, y vigilancia por un adulto. La radiografía de cráneo no tiene rol.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 97 · texto original del banco, sin revisar

Un adolescente de 17 años sufre un accidente de tránsito, en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente está sin signos neurológicos focales, con escala de Glasgow de 15. Se solicita una radiografía de cráneo que muestra una fractura de la escama del temporal. A las 2 horas evoluciona con cefalea intensa y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Se aprecia midriasis derecha, arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hematoma subdural derecho
B) Hematoma epidural derecho
C) Hemorragia subaracnoidea
D) Contusión encefálica frontal
E) Contusión encefálica temporal

Respuesta B. Es un hematoma epidural clásico, tanto por la fractura, como por la clínica de HTEC grave, como por el breve intervalo lúcido.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 142 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 72 años sufre una caída en bicicleta, golpeando la cabeza contra el suelo. Es llevado a un servicio de urgencia donde se encuentra en buenas condiciones, sin alteraciones del nivel de conciencia ni del examen neurológico, por lo que es dado de alta a su domicilio, con indicación de reposo y control SOS. Tres días después inicia cefalea progresiva y, al día siguiente, se agregan vómitos y dificultad para mover las extremidades derechas. Al examen Fsico se encuentra vigil, orientado en el espacio, pero desorientado en el 8empo. En el examen neurológico destaca hemiparesia derecha. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hematoma epidural
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Hematoma intraparenquimatoso
D) Trombosis del seno cavernoso
E) Hematoma subdural

Respuesta E. Todo adulto mayor con un TEC debe ser estudiado con TAC de cerebro y cráneo, precisamente porque Genen mayor riesgo de presentar un hematoma subdural. Además, es frecuente que se demore en desarrollar síntomas y alteraciones neurológicas, porque se origina en un sangrado venoso, que puede ser bastante lento. La edad avanzada y la atrofia cerebral son los factores de riesgo más importantes, ya que p

1.10.2.021 Traumatismo raquimedular

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar lesión raquimedular en todo politraumatizado (caída de altura, zambullida, alta energía) con dolor cervical, déficit motor o sensitivo, o compromiso de conciencia.
- Restricción de movimiento: collar cervical rígido y tabla espinal, movilización en bloque; vía aérea con tracción mandibular e inmovilización manual alineada.
- Shock neurogénico (lesión cervical o torácica alta): hipotensión con bradicardia y piel tibia y seca; fluidos EV y vasopresor (noradrenalina), atropina si la bradicardia es sintomática; descartar antes hemorragia.
- Examen: nivel motor y sensitivo, tono del esfínter anal, priapismo; respiración diafragmática en lesiones cervicales altas.
- Imagen: TAC de columna (la radiografía lateral solo vale si se ve hasta C7-T1); RM si hay déficit neurológico.
- Sonda vesical, prevención de úlceras y TVP. Seguimiento: derivar a neurocirugía o traumatología y luego a rehabilitación.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 97

Adolescente de 17 años sufre un accidente de tránsito en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente está sin signos neurológicos focales, con Glasgow 15. Una radiografía de cráneo muestra una fractura de la escama del temporal. A las 2 horas evoluciona con cefalea intensa y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Se aprecia midriasis derecha, arreactiva. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hematoma subdural derecho
B) Hematoma epidural derecho
C) Hemorragia subaracnoidea
D) Contusión encefálica frontal
E) Contusión encefálica temporal

Respuesta B. Fractura de la escama temporal, intervalo lúcido de dos horas y deterioro brusco con midriasis unilateral son el cuadro clásico del hematoma epidural, por rotura de la arteria meníngea media bajo la fractura.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 142

Paciente de 72 años sufre una caída en bicicleta, golpeando la cabeza contra el suelo. Es evaluado en el servicio de urgencia, donde se encuentra en buenas condiciones, sin alteraciones del nivel de conciencia ni del examen neurológico, y es dado de alta con indicación de reposo y control. Tres días después inicia cefalea progresiva, y al día siguiente se agregan vómitos y dificultad para mover las extremidades derechas. Al examen está vigil, orientado en el espacio pero desorientado en el tiempo, con hemiparesia derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hematoma epidural
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Hematoma intraparenquimatoso
D) Trombosis del seno cavernoso
E) Hematoma subdural

Respuesta E. La edad avanzada, la atrofia cerebral y un mecanismo de sangrado venoso lento explican que los síntomas del hematoma subdural aparezcan varios días después de un golpe que inicialmente pareció leve, algo que no ocurre con el epidural.

Pregunta de práctica

Hombre de 19 años recibe un golpe con un palo en la región temporal izquierda durante un asalto. Pierde el conocimiento por un minuto, se recupera por completo, y queda conversando normalmente en la ambulancia. Una hora y media después, en urgencias, empieza con cefalea intensa, vomita, y en minutos queda en coma, con la pupila izquierda dilatada y sin reflejo a la luz. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemorragia subaracnoidea aneurismática
B) Hematoma epidural agudo
C) Hematoma subdural crónico
D) Contusión cerebral bifrontal
E) Trombosis del seno venoso

Respuesta B. El golpe temporal, la pérdida de conciencia inicial, el intervalo lúcido de más de una hora y el colapso súbito con midriasis ipsilateral son el cuadro clásico del hematoma epidural agudo, por rotura de la arteria meníngea media.

Pregunta de práctica

Hombre de 24 años cae de 4 metros de altura y llega con collar cervical. Está vigil, con vía aérea permeable y ventilación adecuada. Presenta tetraplejia flácida con nivel sensitivo en C6, PA 78/40 mmHg, FC 50/min y piel tibia y seca en extremidades. Eco-FAST negativa y radiografía de pelvis normal. **¿Cuál es la causa más probable de la hipotensión y su manejo inicial?**

A) Shock hipovolémico; transfusión masiva
B) Shock cardiogénico; dobutamina
C) Shock neurogénico; fluidos endovenosos y vasopresor (noradrenalina), con atropina si la bradicardia es sintomática
D) Taponamiento cardíaco; pericardiocentesis
E) Shock séptico; antibióticos de amplio espectro

Respuesta C. La lesión medular cervical o torácica alta interrumpe el tono simpático y produce shock neurogénico: hipotensión con bradicardia y piel tibia, a diferencia del hipovolémico, que es frío y taquicárdico. Tras descartar sangrado, se trata con fluidos y vasopresores (atropina si la bradicardia es sintomática), manteniendo restricción de movimiento de la columna.

Conocimientos generales 2 códigos

1.10.3.001 Manifestaciones neurológicas de abuso de sustancias y alcohol

Dónde se enseña: Tema 17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- Intoxicación alcohólica: ataxia, disartria, nistagmo y compromiso de conciencia; descartar hipoglicemia, TEC (hematoma subdural) y otras drogas.
- Abstinencia: temblor y disautonomía (6–12 h), alucinosis con sensorio lúcido (12–24 h), convulsiones (12–48 h) y delirium tremens (48–96 h, confusión, fiebre, zoopsias). Benzodiacepinas guiadas por CIWA-Ar: diazepam; lorazepam si cirrosis.
- Encefalopatía de Wernicke (déficit de tiamina): oftalmoplejía (VI par, nistagmo), ataxia y confusión (la tríada completa solo en 30%); tiamina 100–300 mg EV antes de cualquier glucosado. Secuela: Korsakoff (amnesia anterógrada y confabulación).
- Daño crónico: degeneración cerebelosa vermiana, polineuropatía, demencia alcohólica, mielinolisis pontina por corrección rápida del sodio.
- Otras drogas: cocaína (ACV, convulsiones; benzodiacepinas, no betabloqueadores), opioides (miosis y bradipnea: naloxona), benzodiacepinas (flumazenil contraindicado en usuarios crónicos).
- Prevención en APS: tamizaje con AUDIT, intervención breve y entrevista motivacional; naltrexona, disulfiram o acamprosato en programa especializado.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 17.15

Un hombre de 52 años en situación de calle con antecedente de alcoholismo crónico severo y desnutrición extrema es llevado a urgencias por compromiso de conciencia progresivo. Al examen físico destaca sopor profundo, nistagmo bilateral horizontal y ataxia de tronco que le impide la bipedestación. La glicemia capilar informa 48 mg/dL. ¿Cuál es la secuencia farmacológica obligatoria que debe administrarse de inmediato?

A) Administrar 4 ampollas de suero glucosado al 30% EV en bolo rápido y luego evaluar vitaminas
B) Administrar Tiamina 100 mg endovenosa o intramuscular previo o simultáneo a la infusión de suero glucosado
C) Administrar Fenitoína 1 g en infusión endovenosa rápida
D) Administrar Naloxona 0.4 mg EV y Flumazenil 0.5 mg EV directo
E) Administrar Insulina cristalina 10 UI subcutáneas

Respuesta B. El paciente presenta la tríada clásica de la Encefalopatía de Wernicke (oftalmoplejía/nistagmo, ataxia y confusión/sopor) agravada por hipoglicemia severa. La regla de oro absoluta e innegociable en urgencias es que en todo paciente con alcoholismo crónico o desnutrición severa, la administración de TIAMINA (Vitamina B1, 100 a 300 mg EV o IM) DEBE preceder o administrarse de forma estrictamente simultánea al suero glucosado. Administrar glucosa sola (A) consume la escasa tiamina de reserva como cofactor metabólico, precipitando la necrosis hemorrágica irreversible de los cuerpos mamilares y el tronco encefálico (Síndrome de Korsakoff o muerte). La fenitoína (C) no previene ni trata el Wernicke. Perla de examen: La Tiamina se administra SIEMPRE antes de la glucosa en el paciente alcohólico para evitar desencadenar una encefalopatía de Wernicke irreversible.

1.10.3.002 Prevención de factores de riesgo cerebrovascular

Dónde se enseña: Tema 10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES · Tema 10.2 Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- La HTA es el principal factor de riesgo modificable de ACV isquémico y hemorrágico; otros: FA, diabetes, dislipidemia, tabaco, sedentarismo, obesidad y alcohol.
- Prevención primaria: PA <140/90 (<130/80 en alto riesgo), dejar de fumar, actividad física, dieta con sal <5 g/día, control glicémico y estatina según riesgo cardiovascular (Programa de Salud Cardiovascular).
- Fibrilación auricular: anticoagulación oral según CHA_2DS_2-VASc (anticoagulantes directos o acenocumarol).
- Prevención secundaria no cardioembólica: AAS 100 mg indefinido (AAS + clopidogrel solo 21 días tras AIT o ACV menor), atorvastatina de alta intensidad con LDL <70, PA <130/80.
- Estenosis carotídea sintomática 70–99% (50–69% en hombres): endarterectomía en <2 semanas; cardioembólico: anticoagular.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 151

Una paciente de 67 años presenta un cuadro de hemiparesia faciobraquiocrural derecha autolimitada hace 7 días, manejada adecuadamente en el hospital. Al examen físico se ausculta un soplo cervical izquierdo, sin otras alteraciones. Su examen neurológico es normal. **¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para realizar el estudio etiológico?**

A) Ecocardiograma Doppler color
B) Angiografía de arterias cerebrales o de cabeza y cuello
C) Resonancia magnética de cerebro
D) Ecodoppler de carótidas
E) TAC de cerebro

Respuesta D. AIT carotídeo izquierdo con soplo cervical del mismo lado: la sospecha es una estenosis carotídea ipsilateral. El eco-Doppler carotídeo es el examen de estudio vascular; si confirma una estenosis significativa, se indica endarterectomía precoz.

Pregunta de práctica

Hombre de 66 años, hipertenso y dislipidémico, egresa tras un infarto cerebral lacunar capsular izquierdo con buena recuperación. Fuma 10 cigarrillos al día. Ritmo sinusal en Holter de 24 horas y eco-Doppler carotídeo sin estenosis significativa. PA 148/92 mmHg con enalapril, LDL 142 mg/dL, HbA1c 5,6 %. **¿Cuál es la estrategia de prevención secundaria más adecuada?**

A) Anticoagulación oral con acenocumarol de por vida
B) AAS 100 mg/día, estatina de alta intensidad con meta de LDL menor de 70 mg/dL, PA menor de 130/80 mmHg y cesación tabáquica
C) AAS más clopidogrel en forma indefinida
D) Solo optimizar la PA, ya que el infarto lacunar no requiere antiagregante
E) Estatina solo si el LDL supera 190 mg/dL

Respuesta B. Infarto no cardioembólico (ritmo sinusal, sin estenosis carotídea): antiagregación con AAS a largo plazo, estatina de alta intensidad con meta de LDL menor de 70 mg/dL, PA menor de 130/80 mmHg, cese del tabaco y actividad física. La anticoagulación es para cardioembolia; la doble antiagregación indefinida aumenta el sangrado sin beneficio.

Exámenes e imagenología 7 códigos

1.10.4.001 TAC de encefalo y columna

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC · Tema 10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES · Tema 10.3 Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de encéfalo sin contraste: primer examen ante déficit focal agudo, cefalea en trueno, TEC con factores de riesgo o compromiso de conciencia; rápido y disponible.
- Sangre aguda hiperdensa (blanca) desde el primer minuto: hematoma intraparenquimatoso, HSA en cisternas, epidural (lente biconvexa, no cruza suturas) o subdural (semiluna, cruza suturas).
- Infarto: el TAC suele ser normal las primeras horas (un TAC normal es compatible con isquemia y permite trombolizar); signos precoces: arteria cerebral media hiperdensa, borramiento del ribete insular; hipodensidad establecida tras horas.
- El contraste se reserva para tumores y abscesos (realce en anillo) o angioTAC (oclusión de gran vaso, aneurisma, trombosis venosa); la TAC normal no descarta trombosis venosa ni infarto de fosa posterior.
- TAC de columna: de elección en trauma raquídeo (la radiografía lateral cervical solo sirve si se visualiza hasta C7-T1).

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Hombre de 76 años, usuario de acenocumarol por fibrilación auricular, se cae en su casa y se golpea la cabeza. Está con Glasgow 15, sin focalidad neurológica, con un hematoma en la región frontal. **¿Cuál es el examen más adecuado?**

A) Radiografía de cráneo
B) TAC de cerebro con contraste
C) TAC de cerebro sin contraste
D) Resonancia magnética de cerebro
E) No requiere imágenes por tener Glasgow 15

Respuesta C. Edad mayor de 65 años y anticoagulación son factores de alto riesgo de hemorragia intracraneana aun con Glasgow 15. El examen de elección en trauma es la TAC de cerebro sin contraste: rápida, disponible y muestra la sangre aguda como hiperdensa. El contraste podría confundirse con sangre.

Pregunta de práctica

Mujer de 72 años, hipertensa, es traída a urgencia 50 minutos después de iniciar en forma súbita hemiparesia izquierda faciobraquiocrural y disartria. PA 178/96 mmHg, glicemia capilar 132 mg/dL, NIHSS 9. Se activa el código ACV. **¿Cuál es el examen de imagen que debe realizarse en primer lugar?**

A) Resonancia magnética de encéfalo con gadolinio
B) TAC de encéfalo con contraste
C) TAC de encéfalo sin contraste urgente
D) Eco-Doppler carotídeo
E) Electroencefalograma

Respuesta C. Ante un déficit focal agudo, el primer examen es el TAC de encéfalo sin contraste, rápido y disponible, cuyo objetivo principal es descartar hemorragia antes de trombolisis. En las primeras horas el infarto suele no verse, por lo que un TAC normal es compatible con isquemia. El contraste dificulta ver sangre; la RM no debe retrasar el tratamiento.

Pregunta de práctica

Mujer de 69 años, hipertensa mal controlada, presenta cefalea brusca, vómitos y hemiparesia derecha de instalación en minutos. PA 210/118 mmHg, Glasgow 13. Se realiza TAC de encéfalo sin contraste a los 40 minutos del inicio. **¿Qué hallazgo del TAC sin contraste confirma una hemorragia intracerebral aguda?**

A) Hiperdensidad espontánea intraparenquimatosa en los ganglios basales izquierdos
B) Hipodensidad córtico-subcortical en el territorio de la arteria cerebral media
C) Lesión con realce en anillo tras la administración de contraste
D) Pequeñas hipodensidades lacunares en la cápsula interna
E) Hiperdensidad lineal de la arteria cerebral media (signo de la arteria hiperdensa)

Respuesta A. En el TAC sin contraste la sangre aguda es hiperdensa (blanca) desde el primer minuto, por eso es el examen de elección para descartar hemorragia. La hipodensidad en territorio arterial es un infarto establecido (de horas); la arteria hiperdensa es un trombo intraluminal en un ACV isquémico; el realce en anillo sugiere absceso o tumor.

1.10.4.002 Resonancia magnética de encéfalo y columna

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 10.5 Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena · Tema 10.18 Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad

QUÉ HAY QUE SABER

- Resonancia magnética: más sensible que la TAC para fosa posterior, isquemia precoz (difusión), lesiones desmielinizantes, tumores, encefalitis y médula; es más lenta y menos disponible.
- Esclerosis múltiple: lesiones ovoides periventriculares perpendiculares al cuerpo calloso (dedos de Dawson), yuxtacorticales, infratentoriales y medulares; las que captan gadolinio son activas.
- Encefalitis herpética: hiperintensidad temporal asimétrica en T2/FLAIR. Trombosis venosa: venografía por RM (signo del delta vacío). Epilepsia: protocolo para esclerosis mesial y displasias.
- RM de columna urgente ante compresión medular (nivel sensitivo, esfínteres), cauda equina o déficit radicular; en lumbago solo si hay banderas rojas.
- No debe retrasar la trombolisis en el ACV agudo; contraindicada con marcapasos no compatible o cuerpos extraños metálicos.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 32 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados y fumadora, consulta por 5 días de cefalea holocránea progresiva que empeora con el decúbito, con vómitos y visión borrosa transitoria. Fondo de ojo: edema de papila bilateral. Sin déficit focal. TAC de encéfalo sin contraste: normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico más probable?**

A) Resonancia magnética de encéfalo con venografía por resonancia
B) Punción lumbar con medición de presión de apertura
C) Electroencefalograma
D) Repetir el TAC sin contraste en 48 horas
E) Eco-Doppler carotídeo

Respuesta A. Cefalea progresiva con hipertensión endocraneana en una mujer con anticonceptivos y tabaco: sospecha de trombosis venosa cerebral. El TAC sin contraste suele ser normal; se confirma con RM más venografía por RM (o angio-TAC venoso), que muestran el seno trombosado. La punción lumbar no se hace antes de la imagen adecuada, y no diagnostica la trombosis.

Pregunta de práctica

Mujer de 31 años con 10 días de parestesias y debilidad de la pierna derecha. Hace 2 años tuvo una neuritis óptica izquierda que se recuperó. Examen: paresia 4/5 de la extremidad inferior derecha con hiperreflexia y Babinski derecho. Se solicita RM de encéfalo y médula con gadolinio. **¿Qué hallazgo de la RM apoya con mayor fuerza el diagnóstico más probable?**

A) Lesiones ovoides hiperintensas en T2 periventriculares, perpendiculares al cuerpo calloso, más lesiones yuxtacorticales, infratentoriales y medulares
B) Infartos lacunares múltiples en los ganglios basales
C) Atrofia hipocampal bilateral
D) Lesión única con realce en anillo y edema perilesional
E) Hiperintensidad simétrica de ambos tálamos

Respuesta A. Dos episodios separados en tiempo y espacio en una mujer joven: esclerosis múltiple. La RM es el examen clave: lesiones desmielinizantes ovoides periventriculares (dedos de Dawson), yuxtacorticales, infratentoriales y medulares cumplen diseminación en espacio; la coexistencia de lesiones que captan y no captan gadolinio cumple diseminación en tiempo (criterios de McDonald).

1.10.4.003 Angiografía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

QUÉ HAY QUE SABER

- Angiografía cerebral por sustracción digital: estándar de referencia para aneurismas, malformaciones arteriovenosas, estenosis y vasculitis; permite tratar en el mismo acto (embolización con coils, trombectomía).
- Indicada tras confirmar hemorragia subaracnoidea (TAC o punción lumbar) para localizar el aneurisma (15–20% son múltiples).
- En el ACV isquémico con oclusión de gran vaso se usa como vía para la trombectomía mecánica.
- Alternativas no invasivas iniciales: angioTAC y angio-RM; eco-Doppler para carótidas y Doppler transcraneal para vigilar vasoespasmo.

- Riesgos: nefropatía por contraste, alergia, ACV embólico y hematoma del sitio de punción. El médico general deriva y emplea el informe.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 48 años con cefalea súbita, "la peor de su vida", de 6 horas de evolución. La TAC de cerebro sin contraste muestra hemorragia subaracnoidea en las cisternas basales. **¿Cuál es el examen de referencia para identificar y caracterizar el aneurisma?**
> **A)** Angiografía cerebral por sustracción digital
> **B)** Electroencefalograma
> **C)** Punción lumbar
> **D)** Doppler transcraneal
> **E)** Resonancia magnética sin contraste
> Respuesta A. Confirmada la hemorragia subaracnoidea, debe identificarse el aneurisma. La angiografía cerebral por sustracción digital es el estándar de referencia: lo localiza, lo caracteriza y permite tratarlo con embolización endovascular en el mismo procedimiento. La angio-TAC es una alternativa inicial no invasiva, y el doppler transcraneal sirve para vigilar el vasoespasmo.

1.10.4.004 Campo visual

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 7.20 Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Campo visual por confrontación (en la consulta) o campimetría computarizada; localiza la lesión de la vía óptica.
- Defecto monocular: lesión de retina o nervio óptico (escotoma central en neuritis óptica, con DPAR).
- Hemianopsia bitemporal (heterónima): lesión del quiasma, típicamente macroadenoma hipofisario o craneofaringioma: RM de silla turca y perfil hormonal.
- Hemianopsia homónima contralateral: lesión retroquiasmática (cintilla, radiaciones, corteza occipital); con preservación macular sugiere infarto de la cerebral posterior. Cuadrantanopsia superior: temporal; inferior: parietal.
- La campimetría documenta el daño y se usa en el seguimiento de tumores selares y glaucoma.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 50 años consulta por cefalea y por chocar con frecuencia con objetos a ambos lados al caminar. La resonancia muestra un macroadenoma hipofisario de 2,5 cm con extensión supraselar. **¿Cuál es la alteración del campo visual más esperable?**
> **A)** Hemianopsia homónima derecha
> **B)** Hemianopsia bitemporal
> **C)** Escotoma central unilateral
> **D)** Cuadrantanopsia superior homónima
> **E)** Amaurosis monocular transitoria
> Respuesta B. Un macroadenoma con extensión supraselar comprime el quiasma óptico desde abajo, afectando las fibras nasales que se cruzan, y produce hemianopsia bitemporal, que típicamente se inicia en los cuadrantes superiores. Por eso todo macroadenoma requiere campimetría. La hemianopsia homónima indica una lesión retroquiasmática, y la amaurosis transitoria, isquemia retiniana.

1.10.4.005 Electroencefalograma

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 10.8 Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES · Tema 10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- EEG: examen de elección para apoyar el diagnóstico y clasificar la epilepsia; busca actividad epileptiforme interictal (puntas, ondas agudas, punta-onda).

- Normal en cerca de la mitad de los epilépticos: un EEG normal no descarta epilepsia; aumentar sensibilidad con privación de sueño, registros repetidos o video-EEG.
- Hallazgos típicos: punta-onda generalizada a 3 Hz en ausencias (gatilladas por hiperventilación), hipsarritmia en el síndrome de West, puntas centrotemporales en epilepsia rolándica, complejos periódicos en Creutzfeldt-Jakob.
- Un EEG epileptiforme tras una primera crisis eleva el riesgo de recurrencia (>60%) y apoya iniciar tratamiento.
- EEG continuo en estatus refractario o paciente que no despierta tras una crisis (estatus no convulsivo). GES: EEG en 30 días en epilepsia ≥15 años.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Niña de 7 años, con buen desarrollo, es derivada porque su profesora nota que varias veces al día se queda con la mirada fija por unos 10 segundos, con parpadeo, sin caerse, y retoma la actividad sin confusión. En la consulta se reproduce un episodio al pedirle que hiperventile. **¿Qué hallazgo del electroencefalograma es esperable?**

A) Trazado normal, que descarta epilepsia
B) Hipsarritmia
C) Puntas centrotemporales que aumentan con el sueño
D) Complejos periódicos de ondas agudas
E) Descargas generalizadas de punta-onda a 3 Hz

Respuesta E. Desconexiones breves y frecuentes, sin período postictal y gatilladas por hiperventilación: epilepsia de ausencia infantil. El EEG característico muestra descargas generalizadas y simétricas de punta-onda a 3 Hz. La hipsarritmia corresponde al síndrome de West; las puntas centrotemporales a la epilepsia rolándica; los complejos periódicos a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

Pregunta de práctica

Hombre de 31 años, sano, presenta una primera crisis tónico-clónica generalizada no provocada, presenciada, con mordedura lateral de lengua y confusión postictal de 20 minutos. Examen neurológico y exámenes generales normales; RM de encéfalo normal. El EEG interictal de rutina, realizado a los 5 días, es normal. **¿Cuál es la interpretación más adecuada del EEG?**

A) No descarta epilepsia: un EEG interictal es normal en una proporción relevante de pacientes, y puede repetirse con privación de sueño
B) Descarta epilepsia y permite dar el alta sin controles
C) Confirma una crisis psicógena no epiléptica
D) Indica que la crisis fue un síncope convulsivo
E) Obliga a iniciar fenitoína de inmediato

Respuesta A. El EEG interictal de rutina detecta descargas epileptiformes solo en una parte de los pacientes con epilepsia; su sensibilidad aumenta con registros repetidos, privación de sueño o video-EEG. Un EEG normal no descarta epilepsia, y uno anormal tras una primera crisis aumenta el riesgo de recurrencia y apoya iniciar tratamiento. El diagnóstico sigue siendo clínico.

1.10.4.006 Electromiografía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo · Tema 10.17 Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

QUÉ HAY QUE SABER

- Electromiografía con velocidad de conducción nerviosa: confirma y gradúa neuropatías, radiculopatías, enfermedades de placa y miopatías.
- Túnel carpiano: confirma la lesión del mediano y su severidad, y orienta la cirugía (atrofia tenar o denervación).
- Polineuropatía: distingue desmielinizante de axonal (diabética, alcohólica). Guillain-Barré: onda F prolongada o ausente y bloqueos de conducción.
- Miastenia: decremento >10% en estimulación repetitiva a 3 Hz; la fibra aislada (jitter) es la más sensible. Miopatía: potenciales miopáticos breves y polifásicos.
- Esclerosis lateral amiotrófica: denervación en varios segmentos. El médico general la solicita o deriva y emplea el informe.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 56

Un paciente de 58 años, diabético tipo 2 de larga data, mal controlado, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de tipo urente y que es más intenso en la noche. Al examen físico se aprecia ausencia de la sensibilidad de las extremidades con el uso de monofilamento e importante disminución de los pulsos pedios. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Estudio Doppler vascular de extremidades inferiores
B) Electromiografía
C) Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
D) Angiografía aortofemoral
E) Pletismografía de volumen del pulso de extremidades inferiores

Respuesta B. Dolor urente, de predominio nocturno, con monofilamento alterado: polineuropatía diabética. Su diagnóstico es clínico, pero el examen que la objetiva es la electromiografía. Los pulsos disminuidos son un distractor que lleva a los estudios vasculares.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 27

Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 28 semanas, consulta por parestesias en el primer, segundo y tercer dedo de la mano derecha, que empeoran durante la tarde y la noche, asociadas a sensación de debilidad en los mismos dedos. El resto del examen físico es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?**

A) Resonancia magnética nuclear de cuello
B) Ecografía de muñecas
C) Electromiografía
D) Radiografía de mano derecha
E) Factor reumatoideo

Respuesta C. Túnel carpiano clásico (embarazo, parestesias en los tres primeros dedos, peor en la noche). El examen que lo confirma es la electromiografía con estudio de conducción nerviosa.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 56

Paciente de 58 años, diabético tipo 2 mal controlado, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de tipo urente y más intenso en la noche. Al examen físico se aprecia ausencia de sensibilidad en las extremidades con el uso de monofilamento. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Eco-Doppler de extremidades inferiores
B) Electromiografía
C) Resonancia magnética de columna lumbosacra
D) Angiografía aortofemoral
E) Pletismografía de volumen del pulso de extremidades inferiores

Respuesta B. Dolor urente nocturno y pérdida de sensibilidad al monofilamento en un diabético mal controlado: polineuropatía diabética. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero el examen que la objetiva es la electromiografía con velocidades de conducción. Doppler, angiografía y pletismografía estudian enfermedad arterial, que da claudicación y no un patrón sensitivo distal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 2

Mujer de 50 años consulta por parestesias en ambas manos, mayores a derecha, que la despiertan en la noche, por lo que debe sacudir las manos para aliviarse. Además presenta dificultad para tomar objetos con las manos. **¿Cuál de los siguientes exámenes es el más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Ecografía de mano
B) Electromiografía
C) Prueba de estimulación con edrofonio
D) Resonancia magnética de cuello
E) Radiografía de mano

Respuesta B. Parestesias nocturnas que alivian al sacudir las manos: síndrome del túnel carpiano. Con debilidad para tomar objetos (compromiso motor), se confirma y gradúa con electromiografía y velocidades de conducción del nervio mediano, que además orientan la cirugía. La prueba de edrofonio estudia miastenia, que da fatigabilidad sin síntomas sensitivos.

1.10.4.007 Examen de líquido cefaloraquídeo (citoquímico, bacteriológico)

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino · Tema 10.16 Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo · Tema 10.18 Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad

QUÉ HAY QUE SABER

- Normal: claro, <5 células (mononucleares), proteínas 15–45 mg/dL, glucosa >60% de la sérica. Hacer TAC antes si hay focalidad, papiledema, Glasgow <10, convulsión reciente o inmunodepresión.
- Bacteriana: turbio, PMN >80%, glucosa baja (razón <0,4), proteínas >100, Gram y cultivo. Viral: linfocitos, glucosa normal, proteínas levemente altas. TBC u hongos: linfocitos con glucosa baja (ADA, tinta china).
- Hemorragia subaracnoidea: glóbulos rojos iguales en los 3 tubos y xantocromía desde las 6–12 h; en la punción traumática los glóbulos rojos disminuyen del tubo 1 al 3 y el sobrenadante es claro.
- Guillain-Barré: disociación albúmino-citológica (proteínas altas con <10 células); >50 células sugiere otra causa.
- Esclerosis múltiple: bandas oligoclonales IgG en LCR ausentes en suero e índice de IgG elevado. Encefalitis herpética: pleocitosis linfocítica con eritrocitos y PCR VHS-1 positiva.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años con cefalea súbita de máxima intensidad en segundos, iniciada hace 10 horas durante el ejercicio. Examen neurológico normal. TAC de encéfalo sin contraste a las 8 horas: normal. Se realiza punción lumbar a las 10 horas del inicio. **¿Qué hallazgo del líquido cefalorraquídeo confirma una hemorragia subaracnoídea?**

A) Glóbulos rojos que disminuyen progresivamente del primer al cuarto tubo
B) Bandas oligoclonales de IgG
C) Proteínas elevadas con celularidad normal
D) Glucosa baja con predominio de neutrófilos
E) Xantocromía del sobrenadante tras centrifugar

Respuesta E. La xantocromía (sobrenadante amarillo por bilirrubina de la degradación de la hemoglobina) aparece desde las 6 a 12 horas y confirma sangre previa en el espacio subaracnoídeo. Los glóbulos rojos que disminuyen entre tubos sugieren punción traumática. Glucosa baja con neutrófilos es meningitis bacteriana; las bandas oligoclonales orientan a esclerosis múltiple.

Pregunta de práctica

Mujer de 42 años con 10 días de parestesias en manos y pies y debilidad ascendente simétrica, precedida por una gastroenteritis. Examen: tetraparesia de predominio proximal y arreflexia generalizada, sin nivel sensitivo y con esfínteres conservados. Se realiza punción lumbar. **¿Cuál es el resultado del líquido cefalorraquídeo más compatible con el diagnóstico más probable?**

A) Proteínas 180 mg/dL, 850 células/mm³ con 90 % de neutrófilos y glucosa 20 mg/dL
B) Proteínas 160 mg/dL, 3 células/mm³ y glucosa normal
C) Líquido xantocrómico con 12.000 glóbulos rojos/mm³
D) Proteínas 40 mg/dL, 2 células/mm³ y glucosa normal, con bandas oligoclonales
E) Proteínas 90 mg/dL, 120 células/mm³ de predominio linfocitario y glucosa normal

Respuesta B. Debilidad ascendente arrefléctica tras una infección: síndrome de Guillain-Barré. El LCR típico muestra disociación albúmino-citológica, con proteínas elevadas y menos de 10 células/mm³, más evidente desde la segunda semana. Una pleocitosis mayor de 50 células obliga a buscar otra causa (VIH, linfoma, poliomielitis, enfermedad de Lyme); neutrófilos con glucosa baja es meningitis bacteriana.

Pregunta de práctica

Hombre de 28 años con 1 semana de diplopía e inestabilidad de la marcha. Examen: oftalmoplejía internuclear derecha y ataxia de extremidades. RM: lesiones desmielinizantes periventriculares y en el pedúnculo cerebeloso medio. Se realiza punción lumbar para apoyar el diagnóstico. **¿Qué hallazgo del líquido cefalorraquídeo apoya el diagnóstico de esclerosis múltiple?**

A) Glucosa en LCR de 20 mg/dL
B) Pleocitosis de 600 células/mm³ con predominio de neutrófilos
C) Bandas oligoclonales de IgG presentes en el LCR y ausentes en el suero
D) Proteínas de 450 mg/dL
E) Xantocromía

Respuesta C. En la esclerosis múltiple el LCR suele ser casi normal (proteínas y células normales o levemente elevadas), pero muestra síntesis intratecal de IgG: bandas oligoclonales en el LCR ausentes en el suero, presentes en más del 90 % de los casos. Según McDonald 2017, pueden reemplazar la diseminación en tiempo. Neutrófilos, glucosa baja o proteínas muy altas sugieren otra causa.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 3 códigos

1.10.5.001 Papiloscopia (fondo de ojo)

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Oftalmoscopía directa en sala oscura, idealmente sin dilatar si se evalúa la pupila en un paciente neurológico; examinar papila, vasos, mácula y periferia.
- Papiledema (hipertensión endocraneana): bilateral, papilas solevantadas de bordes borrosos, pérdida del pulso venoso, ingurgitación venosa y hemorragias peripapilares, con agudeza visual conservada al inicio.
- Ante papiledema: neuroimagen urgente antes de cualquier punción lumbar (riesgo de herniación); causas: tumor, hematoma, hidrocefalia, trombosis venosa, hipertensión intracraneal idiopática.
- Neuritis óptica: fondo de ojo normal en 2/3 (retrobulbar), con DPAR y discromatopsia; papilitis unilateral en 1/3.
- Retinopatía hipertensiva (Keith-Wagener-Barker): grado IV con edema de papila = HTA maligna; hemorragias subhialoideas (Terson) en HSA grave; retinopatía diabética en el control anual.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años con obesidad presenta cefalea holocránea progresiva de 2 meses, peor en la mañana y con maniobras de Valsalva, y oscurecimientos visuales transitorios. Examen neurológico sin déficit focal. Se realiza oftalmoscopía directa (fondo de ojo). **¿Qué hallazgo del fondo de ojo indica hipertensión intracraneana?**

A) Microaneurismas y exudados duros
B) Excavación papilar aumentada, con relación copa/disco de 0,8
C) Mancha rojo cereza en la mácula
D) Papilas solevantadas, de bordes borrosos, sin pulso venoso y con hemorragias peripapilares bilaterales
E) Palidez papilar unilateral sin edema

Respuesta D. El edema de papila es el signo cardinal de hipertensión intracraneana: papilas solevantadas de bordes borrosos, pérdida del pulso venoso espontáneo, ingurgitación venosa y hemorragias peripapilares, habitualmente bilateral. En esta paciente sugiere hipertensión intracraneana idiopática, que requiere neuroimagen antes de la punción lumbar. La excavación aumentada es propia del glaucoma.

1.10.5.002 Punción lumbar

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de meningitis o encefalitis, HSA con TAC normal (a las 6–12 h), Guillain-Barré, esclerosis múltiple, hipertensión intracraneal idiopática (presión de apertura).

- Contraindicaciones: signos de hipertensión endocraneana o lesión con efecto de masa (TAC previo si hay focalidad, papiledema, Glasgow <10, convulsión reciente o inmunodepresión), infección en el sitio, coagulopatía (plaquetas bajas, INR alto, anticoagulación).
- Técnica: consentimiento, decúbito lateral en posición fetal o sentado, asepsia, anestesia local, punción en L3-L4 o L4-L5 (línea entre crestas ilíacas) con trocar fino; medir presión de apertura y recolectar 3–4 tubos.
- Enviar citoquímico, Gram y cultivo, PCR viral, bandas oligoclonales u otros según sospecha; en meningitis no retrasar los antibióticos por la punción.
- Complicación más frecuente: cefalea pospunción (ortostática; reposo, hidratación, cafeína, parche hemático); raras: herniación, hematoma epidural, infección.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 39 años, fumadora, consulta por cefalea occipital explosiva que alcanzó su máxima intensidad en segundos hace 3 horas, mientras levantaba peso, con un vómito. Nunca había tenido cefaleas así. PA 150/90 mmHg, vigil, sin rigidez de nuca ni déficit focal. TAC de encéfalo sin contraste: normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Alta con analgesia y control si reaparecen los síntomas
B) Sumatriptán subcutáneo y observación por 2 horas
C) Punción lumbar diferida a las 6–12 horas del inicio para buscar xantocromía
D) Nimodipino 60 mg cada 4 horas y alta
E) Repetir el TAC sin contraste en 1 semana

Respuesta C. Cefalea en trueno: sospecha de HSA hasta demostrar lo contrario. La ausencia de signos meníngeos a las 3 horas no la descarta (tardan 6–12 h). Con TAC normal, la punción lumbar es obligatoria, idealmente a las 6–12 horas para detectar xantocromía. Si es positiva, sigue el estudio vascular (AngioTAC o angiografía).

1.10.5.003 Aplicación de tests neurocognitivos de screening (MoCA, Mini-Cog, Mini-Mental)

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- MMSE (Minimental): 30 puntos, corte <24 ajustado por escolaridad; útil en demencia, poco sensible para deterioro leve (efecto techo en alta escolaridad).
- MoCA: corte <26 (+1 punto si escolaridad ≤12 años); más sensible para deterioro cognitivo leve y funciones ejecutivas.
- Mini-Cog: recuerdo de 3 palabras + test del reloj, rápido para tamizaje; el reloj se altera precozmente en Alzheimer. En el EMPAM se usa el Minimental abreviado (alterado <13 de 19).
- Un test alterado no diagnostica demencia: complementar con evaluación funcional (Pfeffer ≥6 por informante = dependencia; Barthel para actividades básicas) y estudio de causas reversibles.
- Aplicar con el paciente atento, sin delirium (descartarlo con CAM), con lentes y audífonos, en ambiente tranquilo; registrar escolaridad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 74 años, autovalente, acude a su Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) en el CESFAM. Su hija refiere que en el último año olvida conversaciones recientes. En el Minimental abreviado obtiene 11 puntos (de un máximo de 19). **¿Cuál es el paso siguiente más adecuado?**

A) Diagnosticar demencia e iniciar donepezilo
B) Solicitar RM de encéfalo como único estudio
C) Repetir el Minimental abreviado en 2 años
D) Aplicar el cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer a un informante
E) Derivar a psiquiatría por probable depresión

Respuesta D. En el EMPAM, un Minimental abreviado menor de 13 puntos es alterado y se complementa con el cuestionario de Pfeffer, respondido por un familiar: un puntaje de 6 o más indica compromiso funcional y sospecha de demencia, que se confirma con evaluación clínica y estudio de causas reversibles. Un test de screening por sí solo no diagnostica demencia.